Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Santé publique

- Responsables : Pr Isabelle MOMAS, Pr Corinne ALBERTI
- Intervenant : Dr Morgane Michel

Année universitaire 2024-25

Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Santé publique

- Responsables : Pr Isabelle MOMAS, Pr Corinne ALBERTI
- Intervenant : Dr Morgane Michel

Année universitaire 2024-25

Université Paris Cité

Cours n°9 : Précarité et inégalités de santé

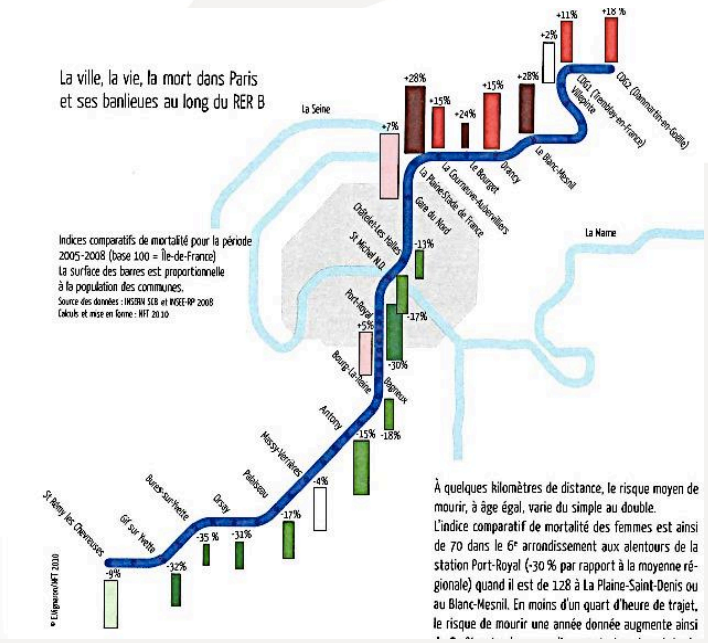
Université Paris Cité

Cours n°9 : Précarité et inégalités de santé

Université Paris Cité

Pourquoi s'y intéresser

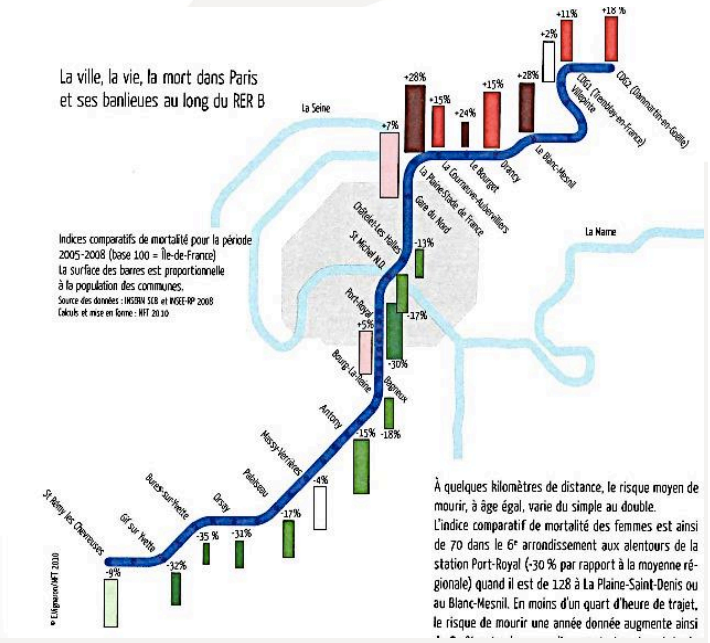
Indice de mortalité relative pour la période de 2005-2008 en Ile-de-France, le long du trajet du RER B



Université Paris Cité

Pourquoi s'y intéresser

Indice de mortalité relative pour la période de 2005-2008 en Ile-de-France, le long du trajet du RER B


La ville, la vie, la mort dans Paris
et ses banlieues au long du RER B
La Seine
La Marne
Indices comparatifs de mortalité pour la période 2005-2008 (base 100 = Île-de-France)
La surface des barres est proportionnelle à la population des communes.
Source des données : INSERM SC8 et INSEE-RP 2008
Calculs et mise en forme : MFT 2010
St Rémy les Chevreuses
Gif sur Yvette
Bures-sur-Yvette
Orsay
Palaiseau
Massy-Verrières
Antony
Bourg la Reine
Bagneux
Port-Royal
Châtelet les Halles
St Michel N.D.
Gare du Nord
La Plaine-Stade de France
La Courneuve-Aubervilliers
Le Bourget
Drancy
Le Blanc-Mesnil
Villepinte
CDG1 (Tremblay-en-France)
CDG2 (Roissy-en-France)
-9%
-32%
-35 %
-31%
-17%
-4%
-15%
-18%
-30%
-17%
-13%
+5%
+7%
+28%
+15%
+24%
+15%
+28%
+2%
+11%
+18 %
À quelques kilomètres de distance, le risque moyen de mourir, à âge égal, varie du simple au double.
L'indice comparatif de mortalité des femmes est ainsi de 70 dans le 6e arrondissement aux alentours de la station Port-Royal (-30 % par rapport à la moyenne régionale) quand il est de 128 à La Plaine-Saint-Denis ou au Blanc-Mesnil. En moins d'un quart d'heure de trajet, le risque de mourir une année donnée augmente ainsi

Université Paris Cité

Pourquoi s'y intéresser

- La France fait partie des pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées
- Elles n'ont pas tendance à régresser alors que le niveau moyen de l'état de santé de la population s'améliore
- Elles sont présentes dès la grossesse

→ Aboutit à une répartition des chances inégale dès le départ
→ Source d'iniquité ++

Université Paris Cité

Pourquoi s'y intéresser

- La France fait partie des pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées
- Elles n'ont pas tendance à régresser alors que le niveau moyen de l'état de santé de la population s'améliore
- Elles sont présentes dès la grossesse

→ Aboutit à une répartition des chances inégale dès le départ
→ Source d'iniquité ++

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Définitions

Inégalités sociales de santé (ISS)

≠

Précarité

≠

Pauvreté

Université Paris Cité

Définitions

Inégalités sociales de santé (ISS)

≠

Précarité

≠

Pauvreté

Université Paris Cité

Définitions

- **Inégalités sociales de santé**

« Différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé » observées entre des groupes sociaux

« Toute relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale » (Guichard et Potvin, 2010)

Université Paris Cité

Définitions

- **Inégalités sociales de santé**

« Différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé » observées entre des groupes sociaux

« Toute relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale » (Guichard et Potvin, 2010)

Université Paris Cité

Définitions

- **Inégalités sociales de santé**

Concernent toute la population
Pas uniquement les plus défavorisés vs. les autres

Elles sont réparties selon un **gradient social** : chaque classe sociale présente un niveau de mortalité et de morbidité plus bas que la classe immédiatement inférieure = association dose-réponse entre la classe sociale et la santé

> NB : valable quand on étudie quelque chose de négatif pour la santé (mortalité, prévalence d'une maladie… → plus c'est élevé, plus c'est mauvais pour l'individu)
> Quand on étudie quelque chose de positif (ex : espérance de vie → plus c'est élevé, mieux c'est), chaque classe sociale présente un niveau plus élevé que la classe immédiatement inférieure

Université Paris Cité

Définitions

- **Inégalités sociales de santé**

Concernent toute la population
Pas uniquement les plus défavorisés vs. les autres

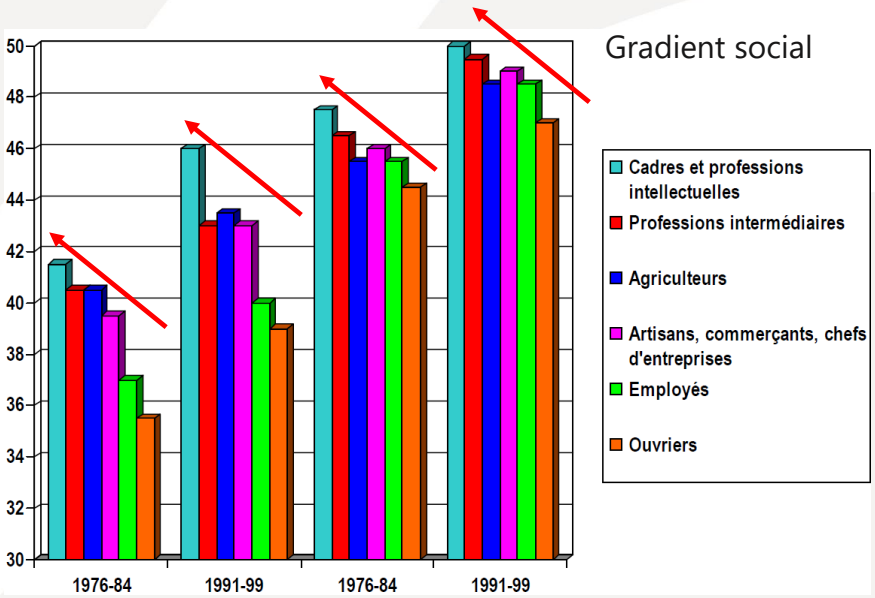
Elles sont réparties selon un **gradient social** : chaque classe sociale présente un niveau de mortalité et de morbidité plus bas que la classe immédiatement inférieure = association dose-réponse entre la classe sociale et la santé

> NB : valable quand on étudie quelque chose de négatif pour la santé (mortalité, prévalence d'une maladie… → plus c'est élevé, plus c'est mauvais pour l'individu)
> Quand on étudie quelque chose de positif (ex : espérance de vie → plus c'est élevé, mieux c'est), chaque classe sociale présente un niveau plus élevé que la classe immédiatement inférieure

Université Paris Cité

Définitions

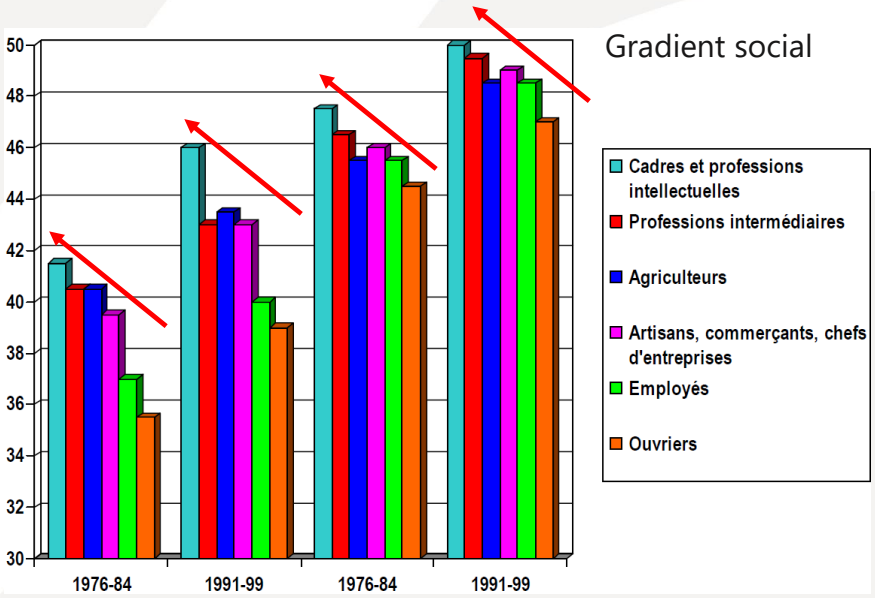
Espérance de vie à 35 ans, des hommes et des femmes en France par catégorie socioprofessionnelle, périodes 1976-84 et 1991-99.



Université Paris Cité

Définitions

Espérance de vie à 35 ans, des hommes et des femmes en France par catégorie socioprofessionnelle, périodes 1976-84 et 1991-99.



Université Paris Cité

Définitions

- **Précarité**

« Absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux »
Multifactoriel, dynamique, réversible

Touche entre 20 et 25% de la population française

Université Paris Cité

Définitions

- **Précarité**

« Absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux »
Multifactoriel, dynamique, réversible

Touche entre 20 et 25% de la population française

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Concept essentiellement économique (≠ précarité)

Différentes façons de la mesurer :
- Pauvreté relative
- Fonction de critères de privation
- Pauvreté absolue

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Concept essentiellement économique (≠ précarité)

Différentes façons de la mesurer :
- Pauvreté relative
- Fonction de critères de privation
- Pauvreté absolue

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Pauvreté relative
Définition d'un seuil de pauvreté monétaire : le plus souvent, 60% du revenu médian français (parfois 50%), en tenant compte de la composition du ménage

En 2019 : 14,6% de la population sous le seuil de 60%
8,2% avec le seuil de 50%

Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage
Unité : euros

	Seuil de 50 %	Seuil de 60 %
Personnes seules	965	1 158
Familles monoparentales avec un enfant de moins de 14 ans	1 255	1 505
Couples sans enfant	1 448	1 737
Couples avec deux enfants de moins de 14 ans	2 027	2 432
Couples avec deux enfants de plus de 14 ans	2 413	2 895

Seuils calculés en pourcentage du niveau de vie médian, après impôts et prestations sociales.
Lecture : le seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian est de 2 413 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans.
Source : Insee – Données 2021 – © Observatoire des inégalités

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Pauvreté relative
Définition d'un seuil de pauvreté monétaire : le plus souvent, 60% du revenu médian français (parfois 50%), en tenant compte de la composition du ménage

En 2019 : 14,6% de la population sous le seuil de 60%
8,2% avec le seuil de 50%

Seuils de pauvreté mensuels selon le type de ménage
Unité : euros

	Seuil de 50 %	Seuil de 60 %
Personnes seules	965	1 158
Familles monoparentales avec un enfant de moins de 14 ans	1 255	1 505
Couples sans enfant	1 448	1 737
Couples avec deux enfants de moins de 14 ans	2 027	2 432
Couples avec deux enfants de plus de 14 ans	2 413	2 895

Seuils calculés en pourcentage du niveau de vie médian, après impôts et prestations sociales.
Lecture : le seuil de pauvreté fixé à 50 % du niveau de vie médian est de 2 413 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans.
Source : Insee – Données 2021 – © Observatoire des inégalités

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Critères de privation : « pauvreté en conditions de vie »
Principe : les conséquence de la pauvreté, c'est l'exclusion de certaines pratiques, de certaines consommations
→ Liste de 27 conséquences (ex : « pouvez-vous chauffer votre logement ? », « avez-vous des impayés de mensualités d'emprunt, de loyer ou de facture ? »)
Si au moins 8 « oui » : pauvreté en conditions de vie

Entre 12 et 14% de la population

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Critères de privation : « pauvreté en conditions de vie »
Principe : les conséquence de la pauvreté, c'est l'exclusion de certaines pratiques, de certaines consommations
→ Liste de 27 conséquences (ex : « pouvez-vous chauffer votre logement ? », « avez-vous des impayés de mensualités d'emprunt, de loyer ou de facture ? »)
Si au moins 8 « oui » : pauvreté en conditions de vie

Entre 12 et 14% de la population

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Pauvreté absolue : définition des biens et services dont la collectivité décide que l'on ne peut priver personne, quoi qu'il arrive (« biens insaisissables »)
Ne dépend pas du niveau de vie de la population

Définition par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale de budgets de référence : liste des biens et services minimaux pour « participer effectivement à la vie sociale ».
→ Budget minimum de 1 400 € / mois pour une personne seule
→ 40% de la population sous le seuil

Université Paris Cité

Définitions

- **Pauvreté**

Pauvreté absolue : définition des biens et services dont la collectivité décide que l'on ne peut priver personne, quoi qu'il arrive (« biens insaisissables »)
Ne dépend pas du niveau de vie de la population

Définition par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale de budgets de référence : liste des biens et services minimaux pour « participer effectivement à la vie sociale ».
→ Budget minimum de 1 400 € / mois pour une personne seule
→ 40% de la population sous le seuil

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Mesure

Difficile de mesurer les inégalités sociales

Pourquoi ?
« La situation socio-économique (SSE) d'un individu est une notion multifactorielle dont la caractérisation nécessite le recueil de plusieurs dimensions et ne peut pas être résumée par un seul indicateur. » (Haut Conseil de la Santé Publique)

Université Paris Cité

Mesure

Difficile de mesurer les inégalités sociales

Pourquoi ?
« La situation socio-économique (SSE) d'un individu est une notion multifactorielle dont la caractérisation nécessite le recueil de plusieurs dimensions et ne peut pas être résumée par un seul indicateur. » (Haut Conseil de la Santé Publique)

Université Paris Cité

Mesure

Classiquement, le statut socio-économique d'un individu est interrogé – au minimum – par une triade :

- Niveau d'éducation
- Situation professionnelle
- Revenus

Université Paris Cité

Mesure

Classiquement, le statut socio-économique d'un individu est interrogé – au minimum – par une triade :

- Niveau d'éducation
- Situation professionnelle
- Revenus

Université Paris Cité

Niveau d'éducation

Le plus utilisé
Avantages
- Reflet des ressources cognitives et intellectuelles d'un individu
- Stable au cours d'une vie
- Ne dépend pas de l'état du marché du travail
- Permet les comparaisons internationales

Inconvénient
- Evolution d'une génération à l'autre avec accroissement continu du nombre d'années d'étude → homogénéisation du niveau de formation dans la population

Université Paris Cité

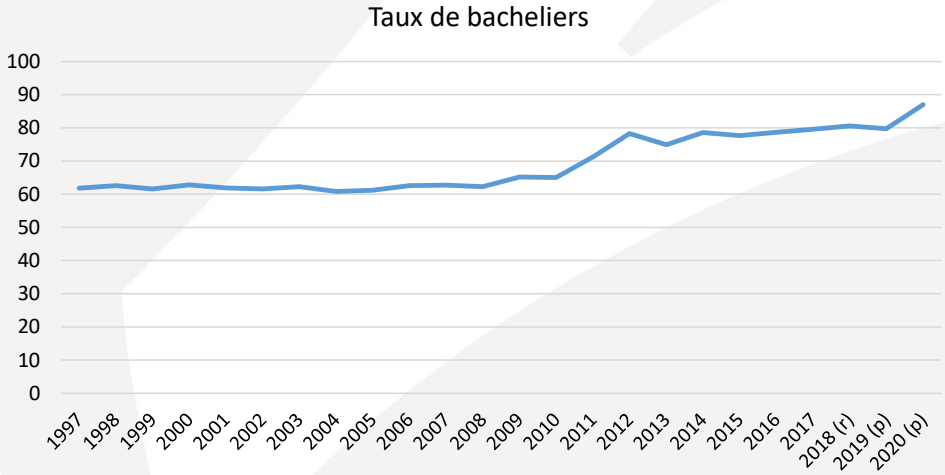
Niveau d'éducation

Le plus utilisé
Avantages
- Reflet des ressources cognitives et intellectuelles d'un individu
- Stable au cours d'une vie
- Ne dépend pas de l'état du marché du travail
- Permet les comparaisons internationales

Inconvénient
- Evolution d'une génération à l'autre avec accroissement continu du nombre d'années d'étude → homogénéisation du niveau de formation dans la population

Université Paris Cité

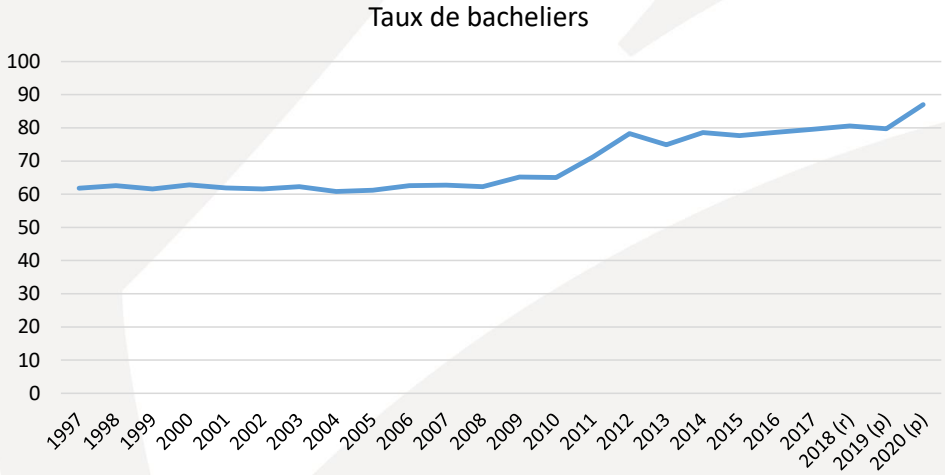
Niveau d'éducation



Champ : France métropolitaine jusqu'en 2000, France métropolitaine + DROM hors Mayotte à partir de 2001.
Sources : Depp ; Insee ; Ministère en charge de l'agriculture.

Université Paris Cité

Niveau d'éducation



Champ : France métropolitaine jusqu'en 2000, France métropolitaine + DROM hors Mayotte à partir de 2001.
Sources : Depp ; Insee ; Ministère en charge de l'agriculture.

Université Paris Cité

Situation professionnelle

Deux dimensions distinctes
- la situation vis-à-vis de l'emploi
- la profession : « professions et catégories sociales » (PCS) de l'INSEE, pouvant être redivisée en 8 groupes socio-professionnels

Inconvénients
- Non stable au cours du temps
- Problème des chômeurs, des retraités, des femmes au foyer
- Les groupes socio-professionnels ne sont pas des groupes sociaux homogènes (revenus très variables au sein d'un groupe)
- Pas de comparaison facile avec la littérature internationale

Université Paris Cité

Situation professionnelle

Deux dimensions distinctes
- la situation vis-à-vis de l'emploi
- la profession : « professions et catégories sociales » (PCS) de l'INSEE, pouvant être redivisée en 8 groupes socio-professionnels

Inconvénients
- Non stable au cours du temps
- Problème des chômeurs, des retraités, des femmes au foyer
- Les groupes socio-professionnels ne sont pas des groupes sociaux homogènes (revenus très variables au sein d'un groupe)
- Pas de comparaison facile avec la littérature internationale

Université Paris Cité

Revenus

Conditionnent l'accès aux biens et aux services dont de nombreux ont une implication sur la santé
Information très « taboue » en France et difficile à recueillir

Recouvre plusieurs notions différentes
- Régularité ?
- Sources ? (patrimoine, salaires, allocations…)
- Part contrainte ? (pensions alimentaires, aides aux proches…)
- Part incompressible ? (dépenses de logement, de transport…)
- Revenus « disponibles »

Université Paris Cité

Revenus

Conditionnent l'accès aux biens et aux services dont de nombreux ont une implication sur la santé
Information très « taboue » en France et difficile à recueillir

Recouvre plusieurs notions différentes
- Régularité ?
- Sources ? (patrimoine, salaires, allocations…)
- Part contrainte ? (pensions alimentaires, aides aux proches…)
- Part incompressible ? (dépenses de logement, de transport…)
- Revenus « disponibles »

Université Paris Cité

Revenus

Si les revenus ne sont pas disponibles, proxy possible : personne bénéficiaire ou non d'un ou plusieurs minima sociaux ou autres prestations sociales attribués sous conditions de ressources

Exemples : revenu de solidarité active (RSA), allocation adulte handicapé (AAH), minimum vieillesse, complémentaire santé solidaire (CSS)…

Université Paris Cité

Revenus

Si les revenus ne sont pas disponibles, proxy possible : personne bénéficiaire ou non d'un ou plusieurs minima sociaux ou autres prestations sociales attribués sous conditions de ressources

Exemples : revenu de solidarité active (RSA), allocation adulte handicapé (AAH), minimum vieillesse, complémentaire santé solidaire (CSS)…

Université Paris Cité

Questionnaires multifactoriels

Score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres d'examens de santé) : utilisé dans les centres de la CNAM

11 questions, score de 0 à 100

Différents domaines
- Revenu
- Logement
- Emploi
- Loisirs
- …

N°	Questions	Oui	Non
1	Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?	10,06	0
2	Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ?	– 11,83	0
3	Vivez-vous en couple ?	– 8,28	0
4	Etes-vous propriétaire de votre logement ?	– 8,28	0
5	Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?	14,80	0
6	Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?	– 6,51	0
7	Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ?	– 7,10	0
8	Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?	– 7,10	0
9	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?	– 9,47	0
10	En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?	– 9,47	0
11	En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ?	– 7,10	0
	Constante	75,14	

Calcul du score : chaque coefficient est ajouté à la constante si la réponse à la question est oui.

Université Paris Cité

Questionnaires multifactoriels

Score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres d'examens de santé) : utilisé dans les centres de la CNAM

11 questions, score de 0 à 100

Différents domaines
- Revenu
- Logement
- Emploi
- Loisirs
- …

N° Questions Oui Non
1 Rencontrez-vous parfois un travailleur social ? 10,06 0
2 Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ? – 11,83 0
3 Vivez-vous en couple ? – 8,28 0
4 Etes-vous propriétaire de votre logement ? – 8,28 0
5 Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ? 14,80 0
6 Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ? – 6,51 0
7 Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ? – 7,10 0
8 Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ? – 7,10 0
9 Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents ou vos enfants ? – 9,47 0
10 En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ? – 9,47 0
11 En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ? – 7,10 0
Constante 75,14

Calcul du score : chaque coefficient est ajouté à la constante si la réponse à la question est oui.

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

« Caractérisation synthétique du niveau socioéconomique de la population à une échelle donnée et à un moment donné » (HCSP)

Obtenus par l'agrégation de différentes variables individuelles (revenus, emploi, etc.), mesurées à une échelle géographique donnée, généralement une petite unité administrative ou territoriale (zone IRIS, code postal…)

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

« Caractérisation synthétique du niveau socioéconomique de la population à une échelle donnée et à un moment donné » (HCSP)

Obtenus par l'agrégation de différentes variables individuelles (revenus, emploi, etc.), mesurées à une échelle géographique donnée, généralement une petite unité administrative ou territoriale (zone IRIS, code postal…)

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

Avantages
- Mesure de la situation socioéconomique des personnes en l'absence de données individuelles
- Permet d'agréger plusieurs indicateurs (revenus, chômage, etc.) en un seul

Inconvénients
- Biais écologique (↓ plus la zone étudiée est petite et homogène)
- Ne prend pas en compte le contexte du milieu de vie
- Calculé à un temps donné, non évolutif
- Traduit autant la richesse d'un territoire que le niveau socio-économique de l'individu qui y habite

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

Avantages
- Mesure de la situation socioéconomique des personnes en l'absence de données individuelles
- Permet d'agréger plusieurs indicateurs (revenus, chômage, etc.) en un seul

Inconvénients
- Biais écologique (↓ plus la zone étudiée est petite et homogène)
- Ne prend pas en compte le contexte du milieu de vie
- Calculé à un temps donné, non évolutif
- Traduit autant la richesse d'un territoire que le niveau socio-économique de l'individu qui y habite

Université Paris Cité

Indicateurs écologiques

Exemples

- FDep : calculé à partir des revenus médians, % bacheliers, % chômeurs et % ouvriers
- EDI (European deprivation index) : calculés à partir du % logements surpeuplés, % sans chauffage central ou électrique, % locataires, % chômeurs, % nationalité étrangère, % sans voiture personnelle, % ouvriers non qualifiés ou agricoles, % niveau d'études faible et % familles monoparentales

Université Paris Cité

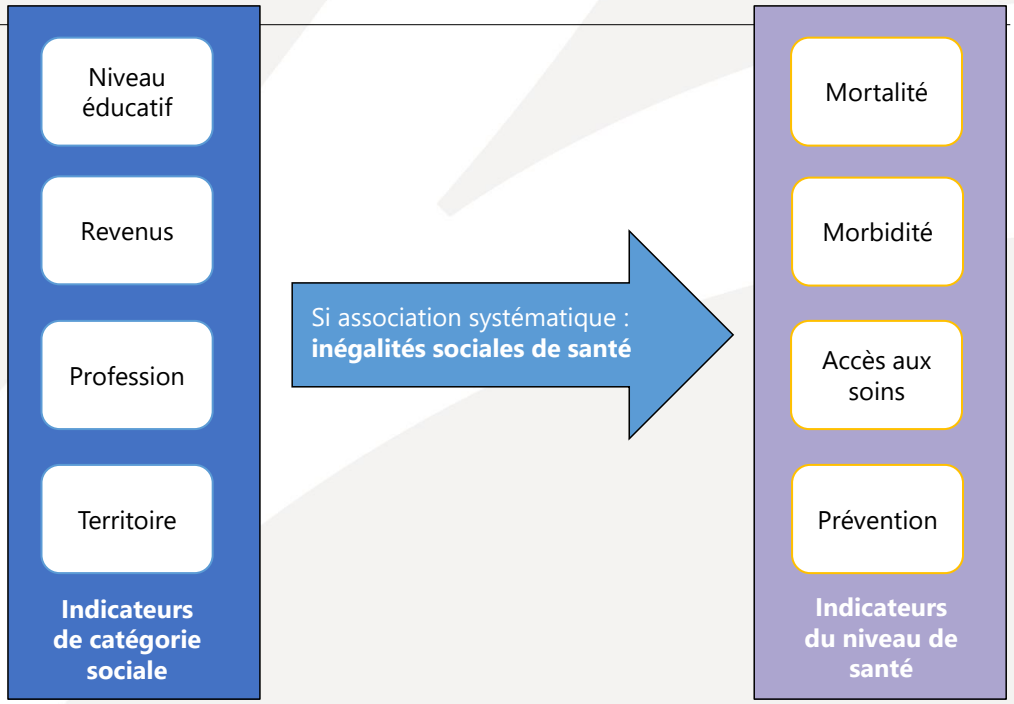
Indicateurs écologiques

Exemples

- FDep : calculé à partir des revenus médians, % bacheliers, % chômeurs et % ouvriers
- EDI (European deprivation index) : calculés à partir du % logements surpeuplés, % sans chauffage central ou électrique, % locataires, % chômeurs, % nationalité étrangère, % sans voiture personnelle, % ouvriers non qualifiés ou agricoles, % niveau d'études faible et % familles monoparentales

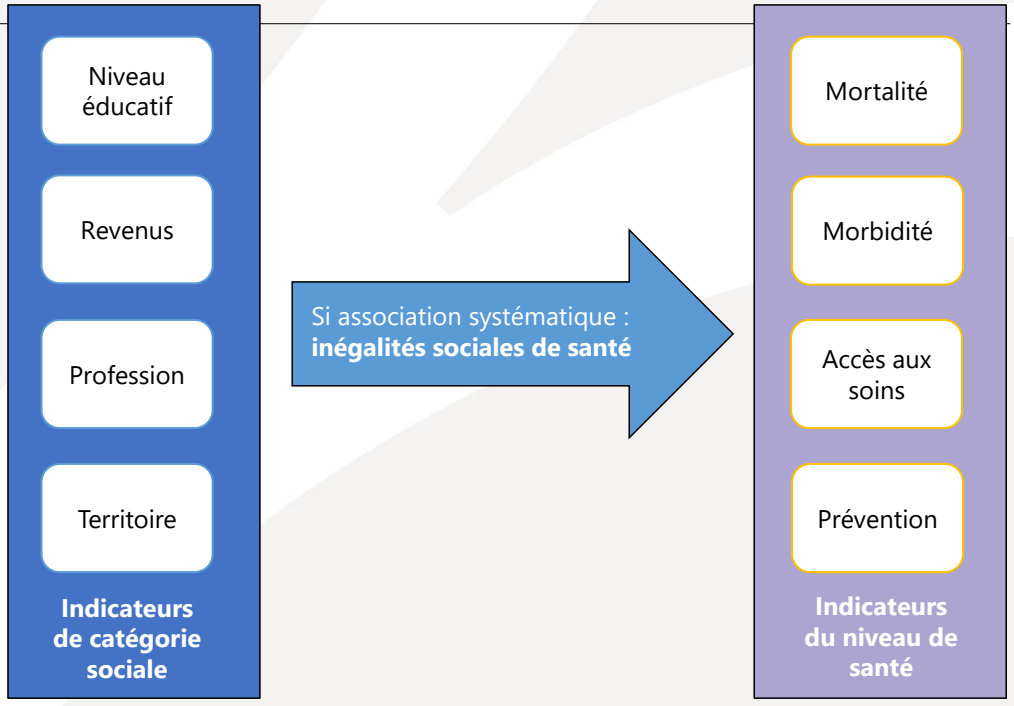
Université Paris Cité

Pour résumer



Université Paris Cité

Pour résumer



Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

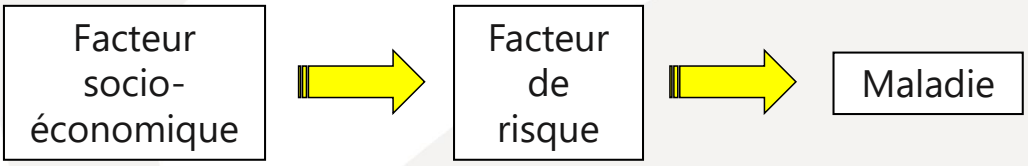
Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Epidémiologie sociale

Approche centrée sur les groupes et non les personnes, conclusions sur les inégalités sociales à partir de la comparaison de ces groupes
Investigation explicite des déterminants sociaux de la santé, de la maladie et du bien-être

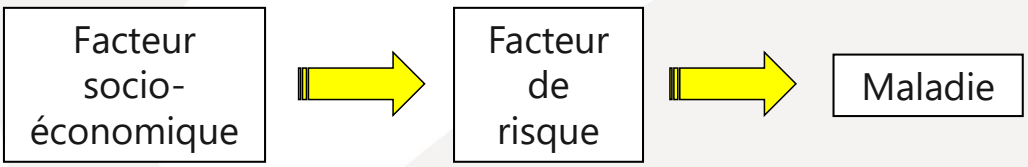


G. Rose Sick Individuals and Sick Populations, Kay-Tee Khaw, Rose's Strategy of Preventive Medicine, Oxford University Press, USA; Updated edition (2008)

Université Paris Cité

Epidémiologie sociale

Approche centrée sur les groupes et non les personnes, conclusions sur les inégalités sociales à partir de la comparaison de ces groupes
Investigation explicite des déterminants sociaux de la santé, de la maladie et du bien-être



G. Rose Sick Individuals and Sick Populations, Kay-Tee Khaw, Rose's Strategy of Preventive Medicine, Oxford University Press, USA; Updated edition (2008)

Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

- Modèle

Permet de modéliser les différents éléments, facteurs et mécanismes qui mènent aux inégalités sociales de santé
C'est un résumé synthétique de ce que l'on met en relation

Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

- Modèle

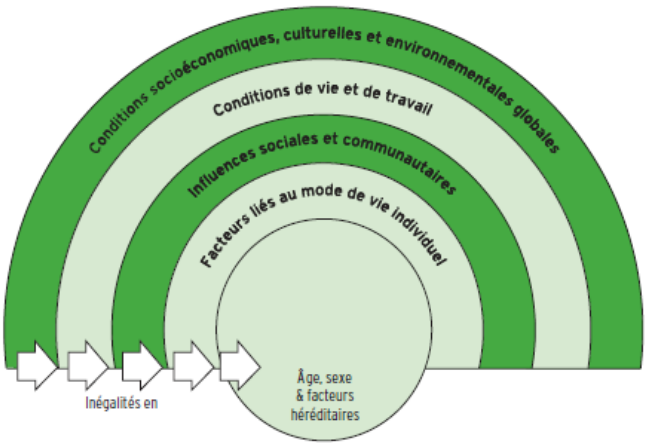
Permet de modéliser les différents éléments, facteurs et mécanismes qui mènent aux inégalités sociales de santé
C'est un résumé synthétique de ce que l'on met en relation

Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

FIGURE 1

Modèle des déterminants de la santé (Dahlgren et Whitehead [15])

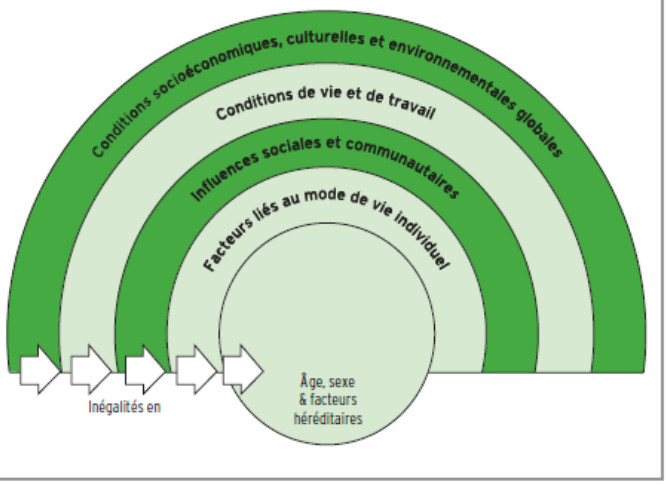


Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

FIGURE 1

Modèle des déterminants de la santé (Dahlgren et Whitehead [15])



Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

- **Niveau 1** : Facteurs liés au style de vie personnel

Comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations entre amis et dans l'ensemble de la collectivité

- **Niveau 2** : Réseaux sociaux et communautaires

Influences sociales et collectives : les interactions sociales et ces pressions des pairs influencent les comportements individuels de façon favorable ou défavorable

- **Niveau 3** : Facteurs liés aux conditions de vie et de travail

Accès au travail, aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, services de santé, nourriture, l'éducation mais aussi les conditions de travail

- **Niveau 4** : Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales

Facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du travail, le mode de fonctionnement du système de santé, ont une incidence sur toutes les autres strates

Université Paris Cité

Modèle des déterminants de la santé

- **Niveau 1** : Facteurs liés au style de vie personnel

Comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations entre amis et dans l'ensemble de la collectivité

- **Niveau 2** : Réseaux sociaux et communautaires

Influences sociales et collectives : les interactions sociales et ces pressions des pairs influencent les comportements individuels de façon favorable ou défavorable

- **Niveau 3** : Facteurs liés aux conditions de vie et de travail

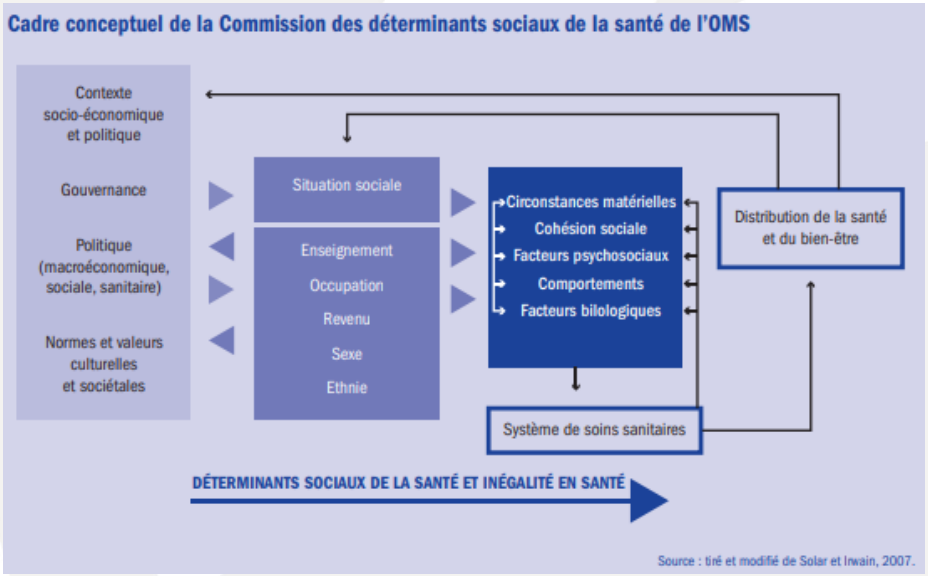
Accès au travail, aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, services de santé, nourriture, l'éducation mais aussi les conditions de travail

- **Niveau 4** : Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales

Facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du travail, le mode de fonctionnement du système de santé, ont une incidence sur toutes les autres strates

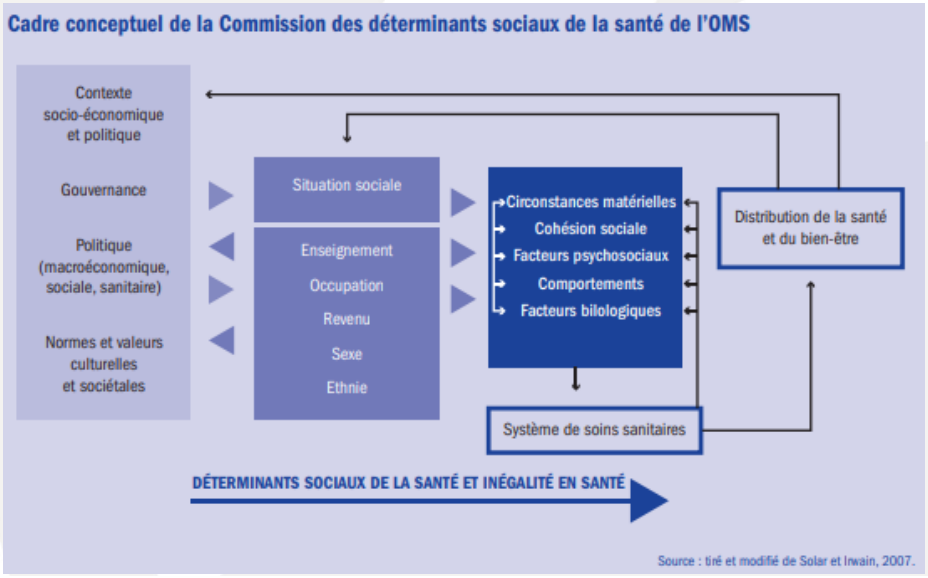
Université Paris Cité

Modèle de l'OMS



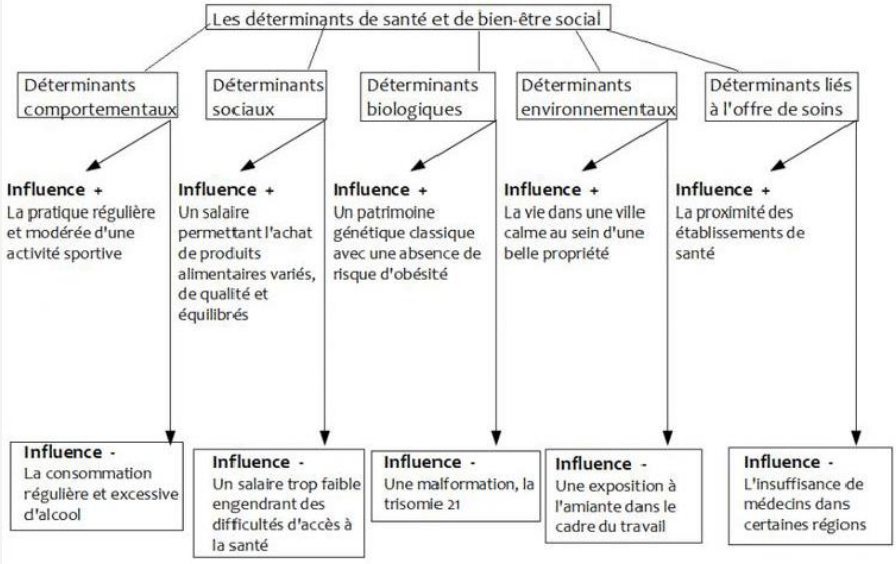
Université Paris Cité

Modèle de l'OMS



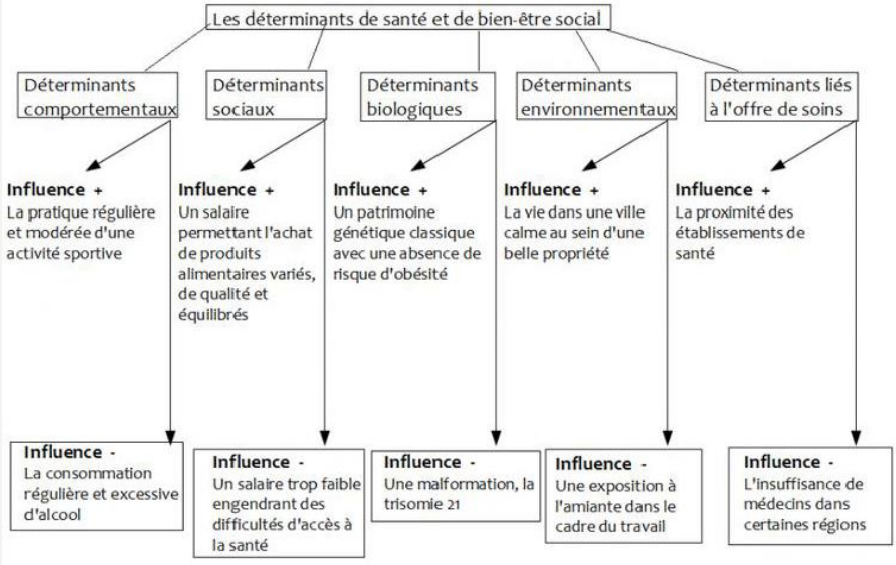
Université Paris Cité

Déterminants de santé



Université Paris Cité

Déterminants de santé



Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Plan du cours

1. Définitions
2. Mesure des ISS
3. Mécanismes
4. Conséquences

Université Paris Cité

Mécanismes d'impact des ISS sur la santé

Les ISS peuvent avoir un impact sur :

- Les déterminants individuels (tabac, alcool, nutrition, activité physique + recours aux soins)
- Les déterminants collectifs (déterminants non-médicaux, expositions professionnelles)
- Les déterminants structurels (accès aux soins : offre de soins, système de santé, territoire)

Université Paris Cité

Mécanismes d'impact des ISS sur la santé

Les ISS peuvent avoir un impact sur :

- Les déterminants individuels (tabac, alcool, nutrition, activité physique + recours aux soins)
- Les déterminants collectifs (déterminants non-médicaux, expositions professionnelles)
- Les déterminants structurels (accès aux soins : offre de soins, système de santé, territoire)

Université Paris Cité

Conséquences sur la santé

- ↑ Mortalité
- ↓ Espérance de vie avec et sans incapacité
- ↑ Maladies chroniques
- ↑ Maladies évitables
- ↓ Santé perçue

Université Paris Cité

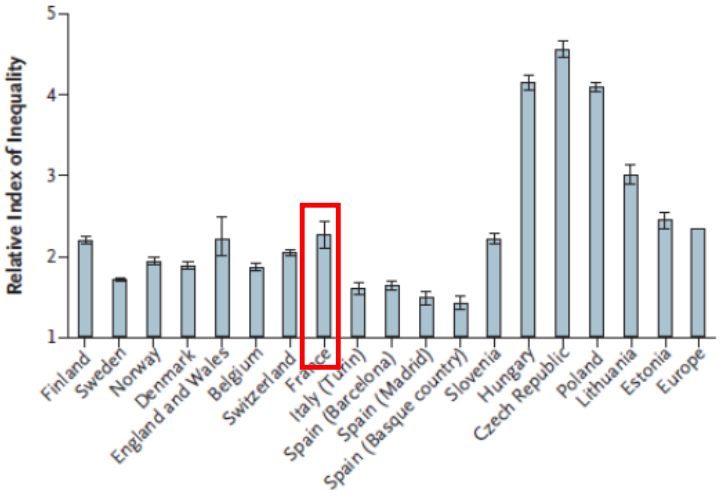
Conséquences sur la santé

- ↑ Mortalité
- ↓ Espérance de vie avec et sans incapacité
- ↑ Maladies chroniques
- ↑ Maladies évitables
- ↓ Santé perçue

Université Paris Cité

Mortalité

La France est un des pays d'Europe de l'ouest avec les ISS les plus marquées



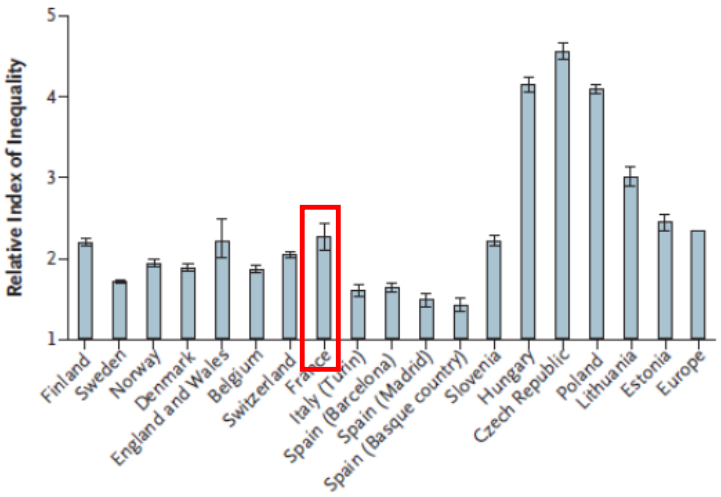
Index relatif d'inégalité dans le taux de mortalité (toute cause) en termes de niveau d'études (= différence entre les plus diplômés et les moins diplômés), hommes

(Mackenbach NEJM 2008)

Université Paris Cité

Mortalité

La France est un des pays d'Europe de l'ouest avec les ISS les plus marquées



Index relatif d'inégalité dans le taux de mortalité (toute cause) en termes de niveau d'études (= différence entre les plus diplômés et les moins diplômés), hommes

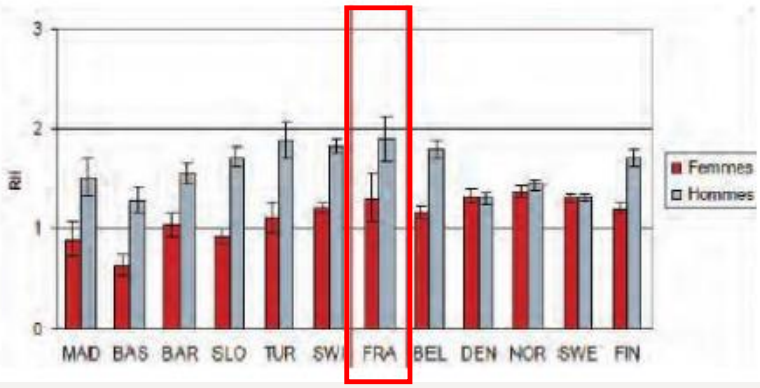
(Mackenbach NEJM 2008)

Université Paris Cité

Mortalité par cancer

La France est un des pays avec les ISS les plus marquées dans la mortalité par cancer

Indice relatif d'inégalités selon le niveau d'études pour la mortalité par cancer dans différents pays d'Europe, 1990-1999. [2]

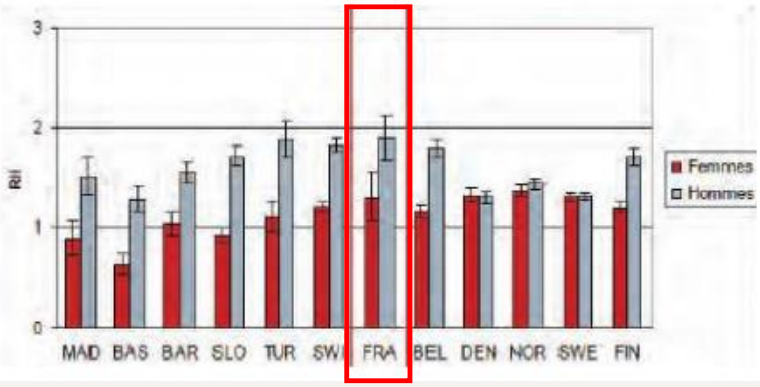


Université Paris Cité

Mortalité par cancer

La France est un des pays avec les ISS les plus marquées dans la mortalité par cancer

Indice relatif d'inégalités selon le niveau d'études pour la mortalité par cancer dans différents pays d'Europe, 1990-1999. [2]

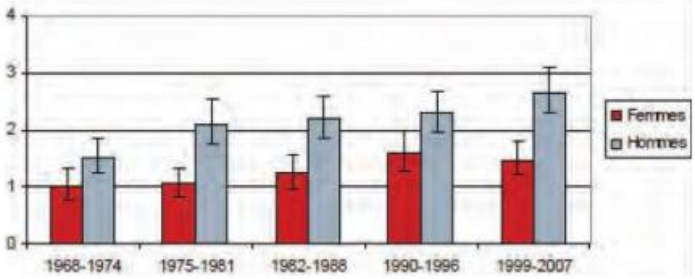


Université Paris Cité

Mortalité par cancer

Ces inégalités s'aggravent avec le temps

Evolution de l'indice relatif d'inégalités selon le niveau d'études pour la mortalité par cancer chez les hommes et les femmes en France, 1968-2007. [2]

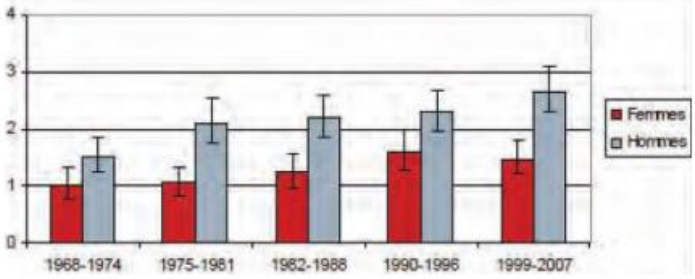


Université Paris Cité

Mortalité par cancer

Ces inégalités s'aggravent avec le temps

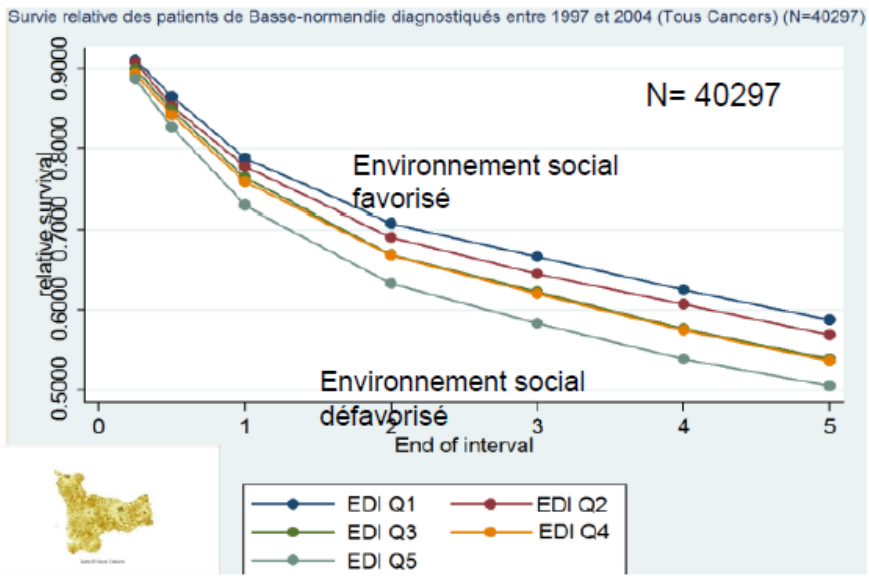
Evolution de l'indice relatif d'inégalités selon le niveau d'études pour la mortalité par cancer chez les hommes et les femmes en France, 1968-2007. [2]



Université Paris Cité

Mortalité par cancer

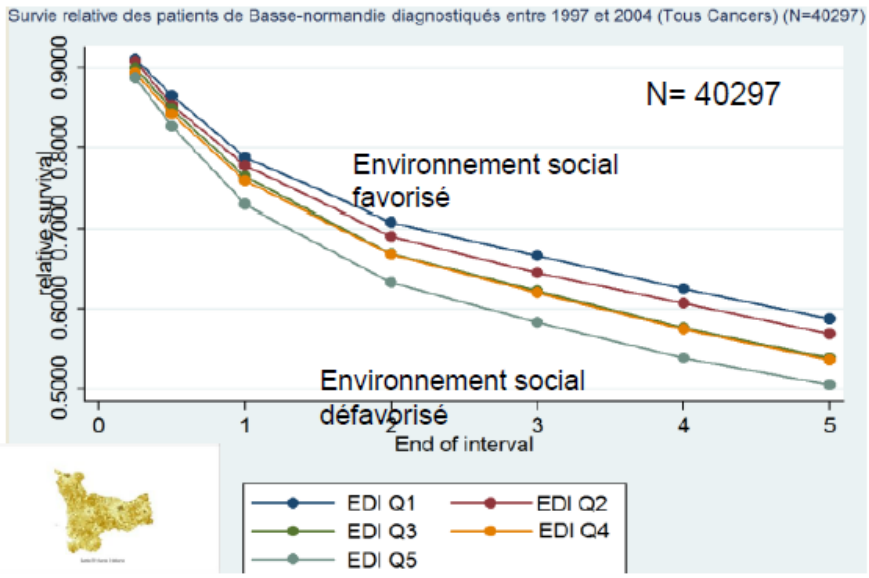
Gradient social dans la survie au cancer : survie moindre si environnement social défavorisé



Université Paris Cité

Mortalité par cancer

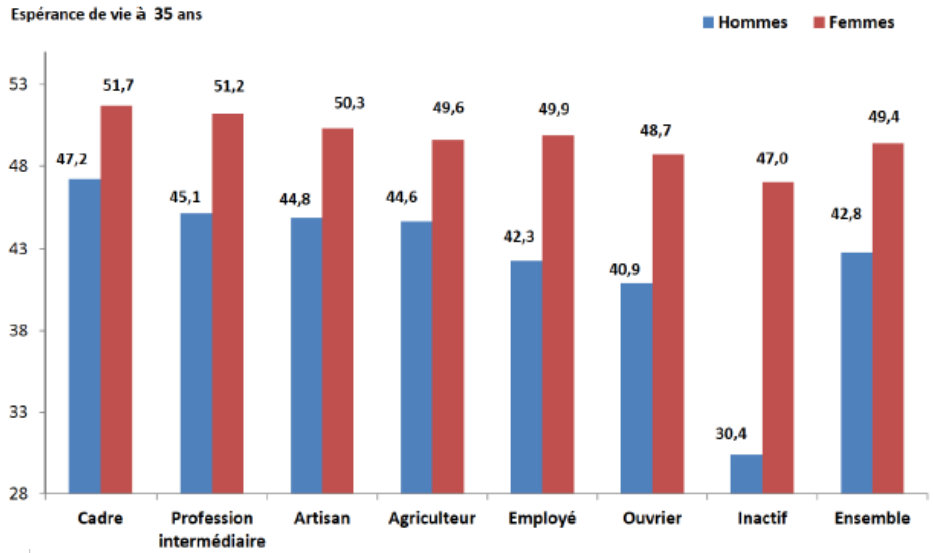
Gradient social dans la survie au cancer : survie moindre si environnement social défavorisé



Université Paris Cité

Espérance de vie

Différences ++ dans l'espérance de vie à 35 ans

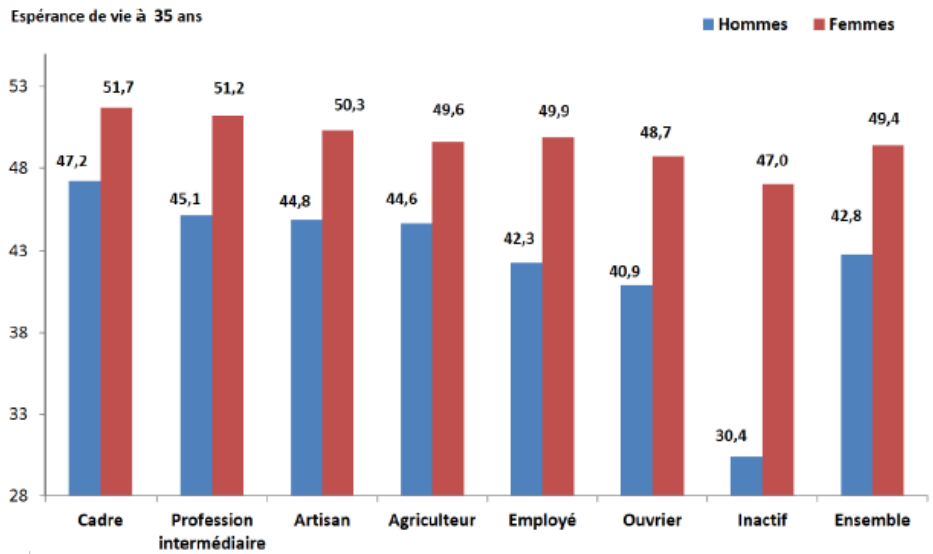


Source : Blanpain N. (2011), "L'espérance de vie s'accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent", Insee Première, 1372.

Université Paris Cité

Espérance de vie

Différences ++ dans l'espérance de vie à 35 ans



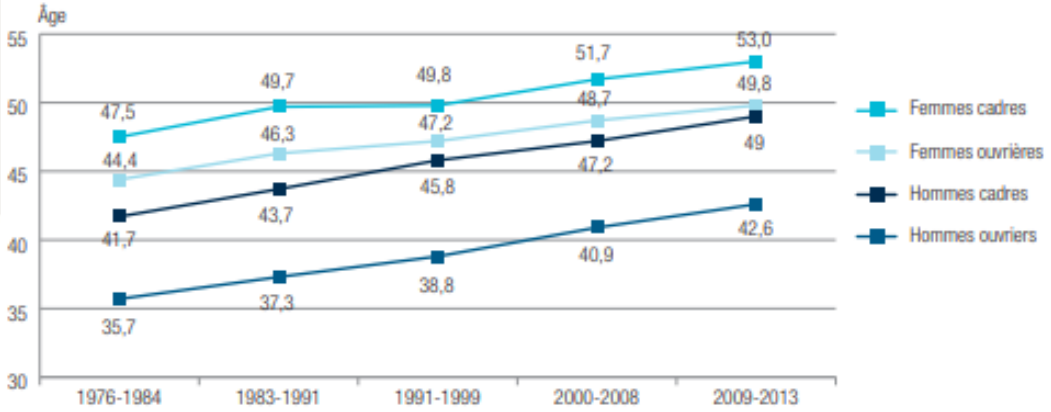
Source : Blanpain N. (2011), "L'espérance de vie s'accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent", Insee Première, 1372.

Université Paris Cité

Espérance de vie

Pas de réduction des écarts avec le temps

Espérance de vie à 35 ans par sexe pour les cadres et les ouvriers



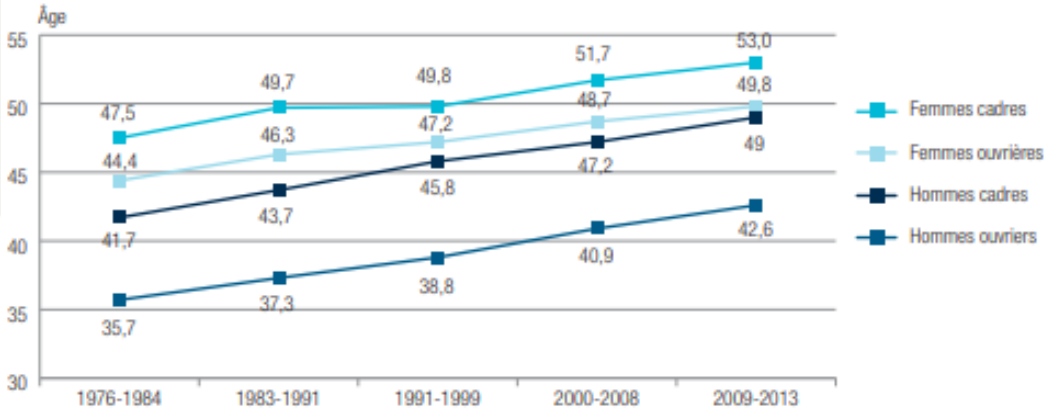
Lecture • En 2000-2008, l'espérance de vie des femmes cadres de 35 ans est de 51,7 ans.
Champ • France métropolitaine.
Source • Échantillon démographique permanent (INSEE).

Université Paris Cité

Espérance de vie

Pas de réduction des écarts avec le temps

Espérance de vie à 35 ans par sexe pour les cadres et les ouvriers

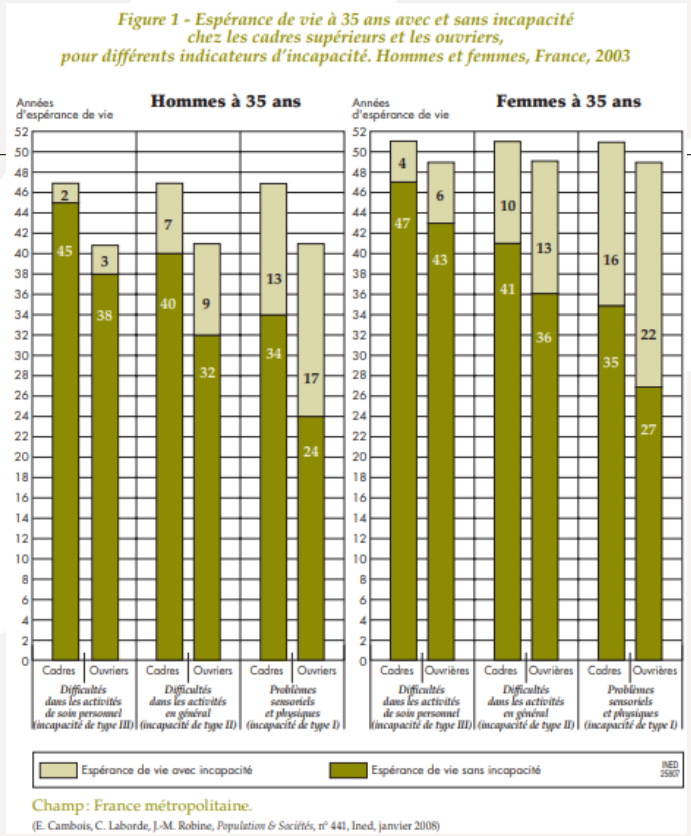


Lecture • En 2000-2008, l'espérance de vie des femmes cadres de 35 ans est de 51,7 ans.
Champ • France métropolitaine.
Source • Échantillon démographique permanent (INSEE).

Université Paris Cité

Espérance de vie

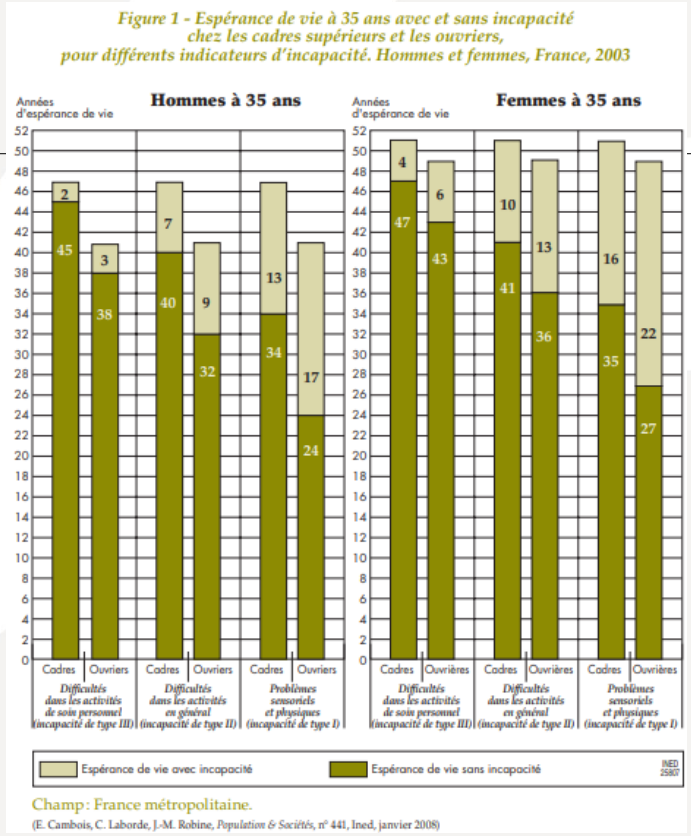
L'espérance de vie n'a pas la même qualité en fonction du groupe socioprofessionnel



Université Paris Cité

Espérance de vie

L'espérance de vie n'a pas la même qualité en fonction du groupe socioprofessionnel


Figure 1 - Espérance de vie à 35 ans avec et sans incapacité chez les cadres supérieurs et les ouvriers, pour différents indicateurs d'incapacité. Hommes et femmes, France, 2003
Hommes à 35 ans
Femmes à 35 ans
Années d'espérance de vie
Cadres
Ouvriers
Ouvrières
Difficultés dans les activités de soin personnel (incapacité de type III)
Difficultés dans les activités en général (incapacité de type II)
Problèmes sensoriels et physiques (incapacité de type I)
Espérance de vie avec incapacité
Espérance de vie sans incapacité
Champ : France métropolitaine.
(E. Cambois, C. Laborde, J.-M. Robine, Population & Sociétés, n° 441, Ined, janvier 2008)

Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ accès au dépistage quand ↓ niveau d'éducation ou des revenus

TABLEAU 2 • **Femmes ayant effectué une mammographie au cours des deux années précédant l'enquête en 2010 en fonction de leur niveau d'éducation et leur niveau de revenu**

Diplôme le plus élevé		Revenus mensuels net du ménage par unité de consommation*	
Sans diplôme	75,9 %	moins de 1 100 euros	75,6 %
Inférieur au bac	82,6 %	1 100 à moins de 1 800 euros	82,5 %
Supérieur au bac	84,0 %	supérieur à 1 800 euros	85,7 %

Champ : Femmes de 50 à 74 ans, France métropolitaine.
Sources : Baromètre santé 2010, Inpes.

Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ accès au dépistage quand ↓ niveau d'éducation ou des revenus

TABLEAU 2 • **Femmes ayant effectué une mammographie au cours des deux années précédant l'enquête en 2010 en fonction de leur niveau d'éducation et leur niveau de revenu**

Diplôme le plus élevé		Revenus mensuels net du ménage par unité de consommation*	
Sans diplôme	75,9 %	moins de 1 100 euros	75,6 %
Inférieur au bac	82,6 %	1 100 à moins de 1 800 euros	82,5 %
Supérieur au bac	84,0 %	supérieur à 1 800 euros	85,7 %

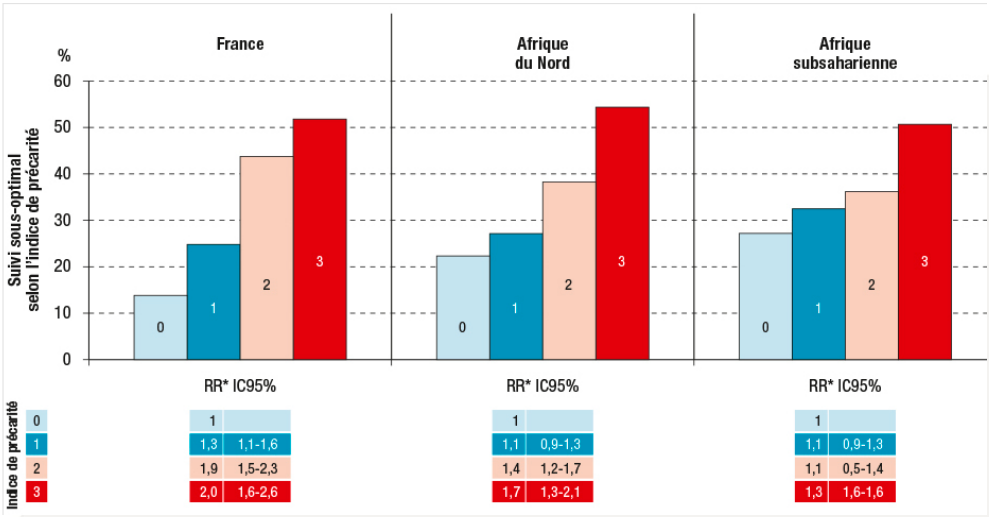
Champ : Femmes de 50 à 74 ans, France métropolitaine.
Sources : Baromètre santé 2010, Inpes.

Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ suivi prénatal adéquat pendant la grossesse quand ↑ précarité

Figure : Suivi prénatal inadéquat en fonction de l'indice de précarité et du lieu de naissance maternel, données de la cohorte PreCARE, France, 2010-2011

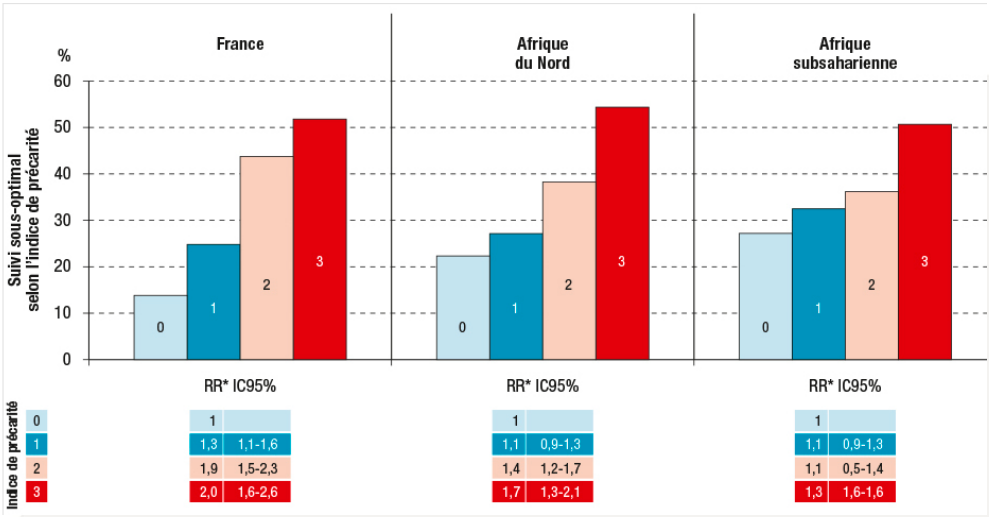


Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ suivi prénatal adéquat pendant la grossesse quand ↑ précarité

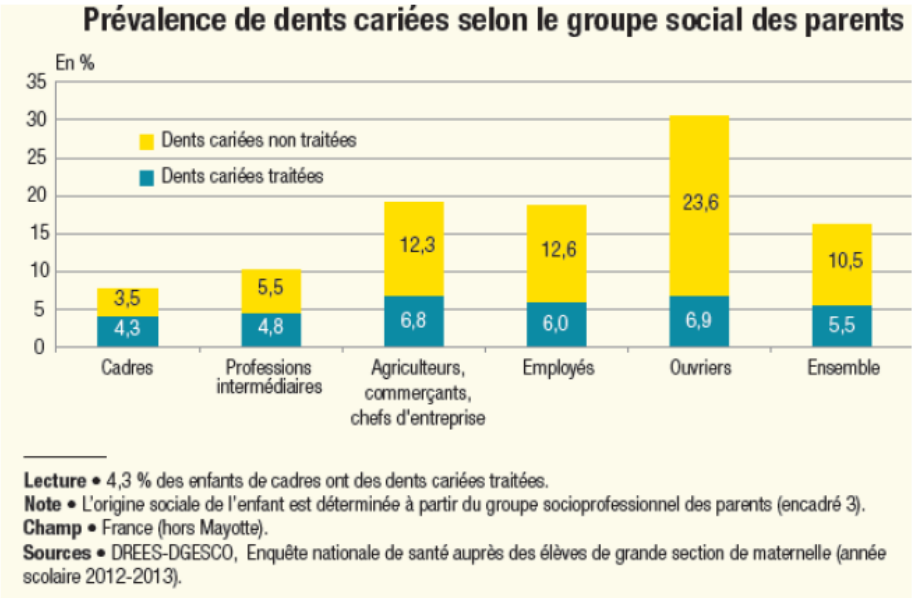
Figure : Suivi prénatal inadéquat en fonction de l'indice de précarité et du lieu de naissance maternel, données de la cohorte PreCARE, France, 2010-2011



Université Paris Cité

Accès aux soins

↑ caries et caries non traitées quand ↓ catégorie professionnelle

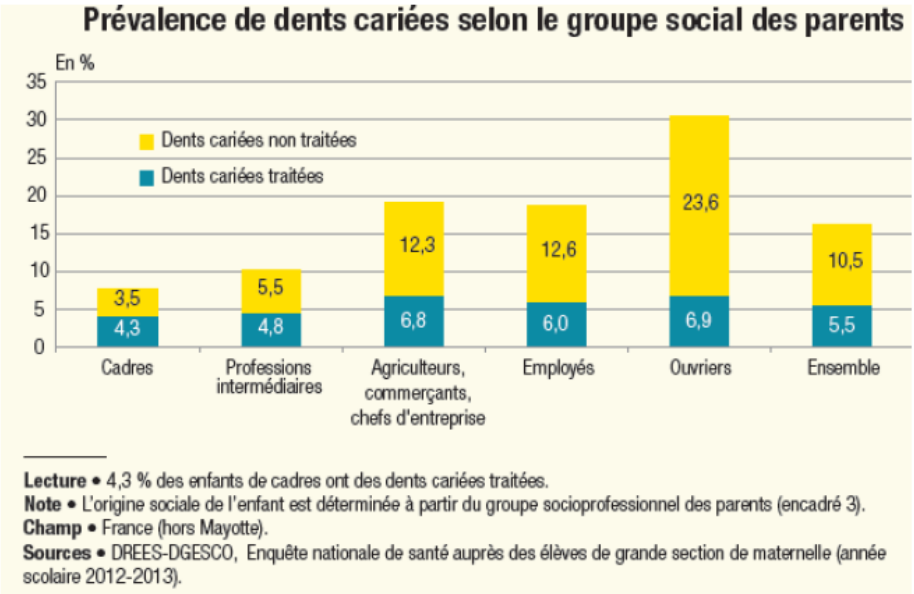


Lecture • 4,3 % des enfants de cadres ont des dents cariées traitées.
Note • L'origine sociale de l'enfant est déterminée à partir du groupe socioprofessionnel des parents (encadré 3).
Champ • France (hors Mayotte).
Sources • DREES-DGESCO, Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (année scolaire 2012-2013).

Université Paris Cité

Accès aux soins

↑ caries et caries non traitées quand ↓ catégorie professionnelle



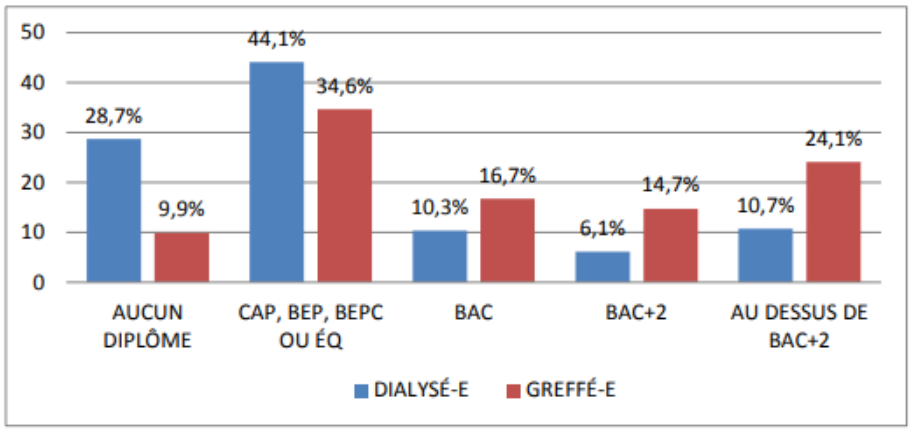
Lecture • 4,3 % des enfants de cadres ont des dents cariées traitées.
Note • L'origine sociale de l'enfant est déterminée à partir du groupe socioprofessionnel des parents (encadré 3).
Champ • France (hors Mayotte).
Sources • DREES-DGESCO, Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (année scolaire 2012-2013).

Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ accès à la greffe rénale quand ↓ niveau d'éducation

Graphique 1 - Répartition des niveaux d'instruction des patients dialysés et greffés (enquête EGR)



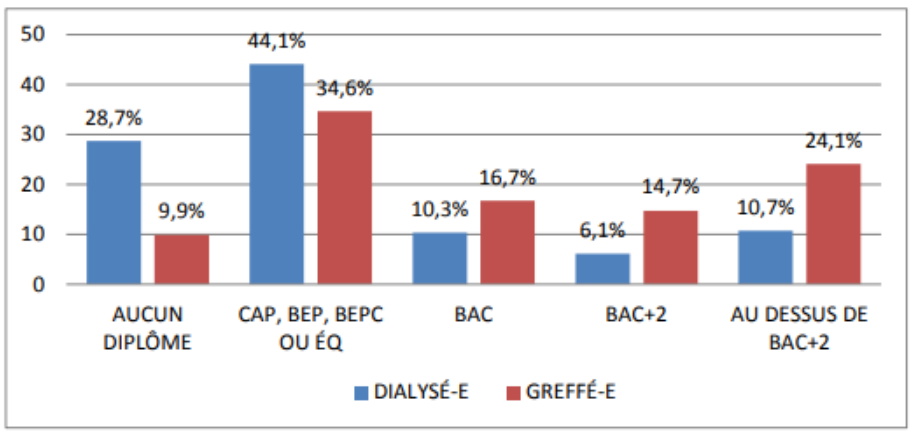
Source : Enquête États généraux du rein

Université Paris Cité

Accès aux soins

↓ accès à la greffe rénale quand ↓ niveau d'éducation

Graphique 1 - Répartition des niveaux d'instruction des patients dialysés et greffés (enquête EGR)



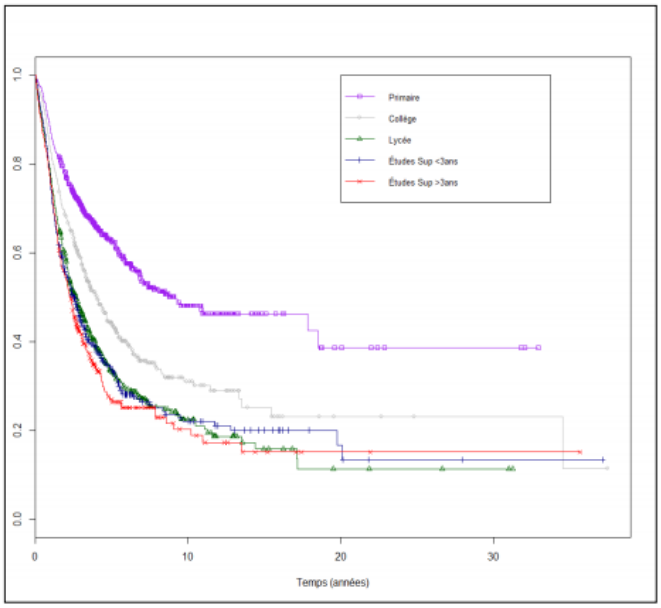
Source : Enquête États généraux du rein

Université Paris Cité

Accès aux soins

Temps d'accès à la greffe beaucoup plus long pour les niveaux d'éducation plus bas

Graphique 2 - Vitesse d'obtention de la greffe de rein dans l'ensemble de la population en insuffisance rénale terminale (IRT), selon le niveau d'études



Note de lecture : Ces courbes de Kaplan-Meier représentent la part de la population en IRT encore en dialyse et n'ayant pas reçu de greffe de rein. Cinq ans après le début de leur dialyse, 62 % des patients ayant une éducation de niveau primaire étaient encore en dialyse.

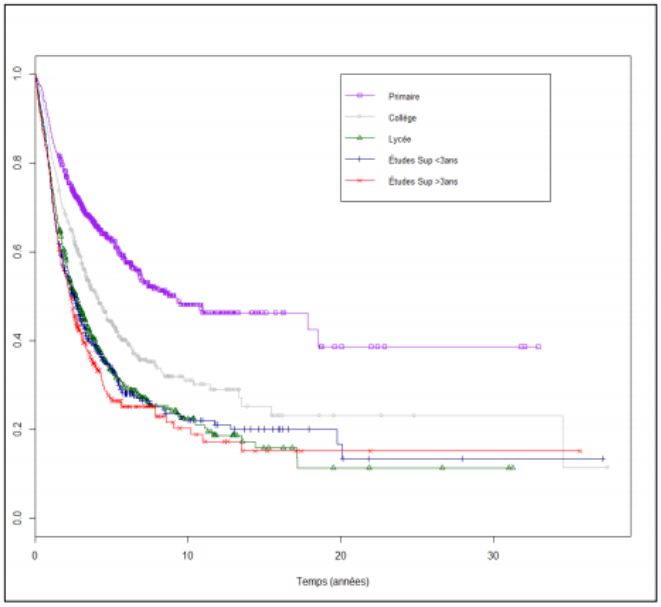
Source : Enquête Quavi-REIN

Université Paris Cité

Accès aux soins

Temps d'accès à la greffe beaucoup plus long pour les niveaux d'éducation plus bas

Graphique 2 - Vitesse d'obtention de la greffe de rein dans l'ensemble de la population en insuffisance rénale terminale (IRT), selon le niveau d'études



Note de lecture : Ces courbes de Kaplan-Meier représentent la part de la population en IRT encore en dialyse et n'ayant pas reçu de greffe de rein. Cinq ans après le début de leur dialyse, 62 % des patients ayant une éducation de niveau primaire étaient encore en dialyse.

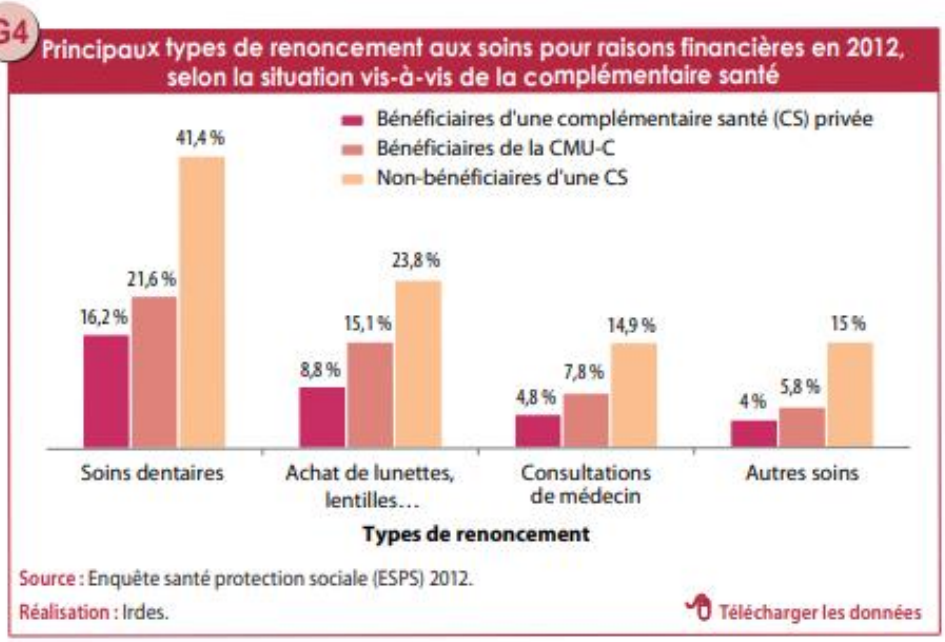
Source : Enquête Quavi-REIN

Université Paris Cité

Accès aux soins

Renoncement aux soins pour raisons financières

Rôle ++ des complémentaires santé dans l'accès aux soins

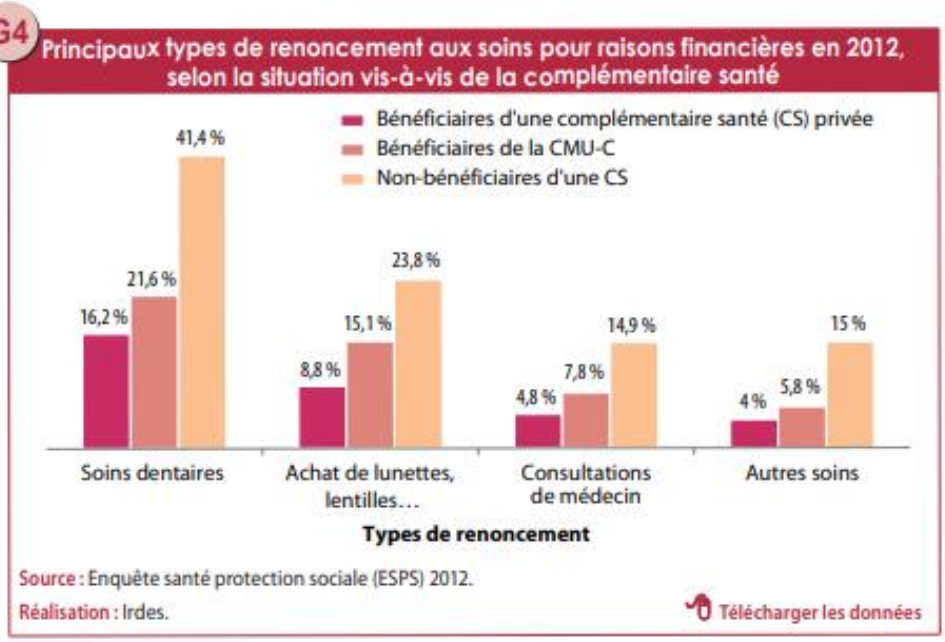


Université Paris Cité

Accès aux soins

Renoncement aux soins pour raisons financières

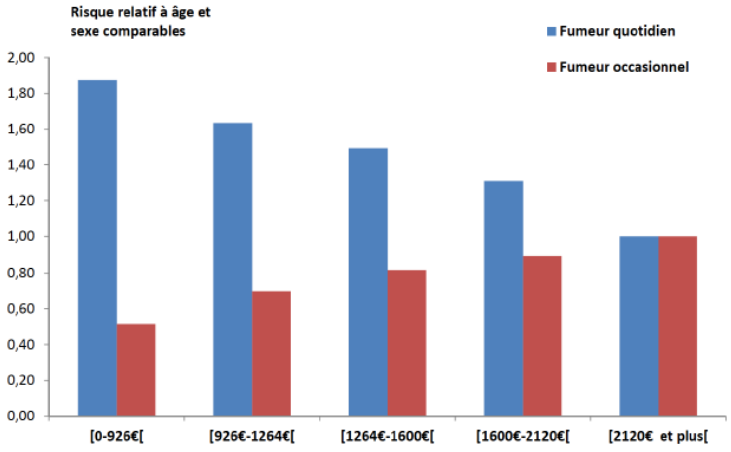
Rôle ++ des complémentaires santé dans l'accès aux soins



Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Quand revenus ↓ :
↑ fumeurs quotidiens
↓ fumeurs occasionnels

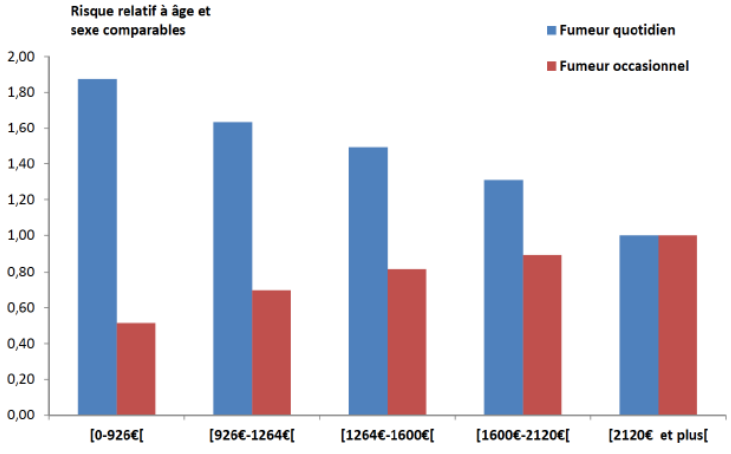


Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Quand revenus ↓ :
↑ fumeurs quotidiens
↓ fumeurs occasionnels

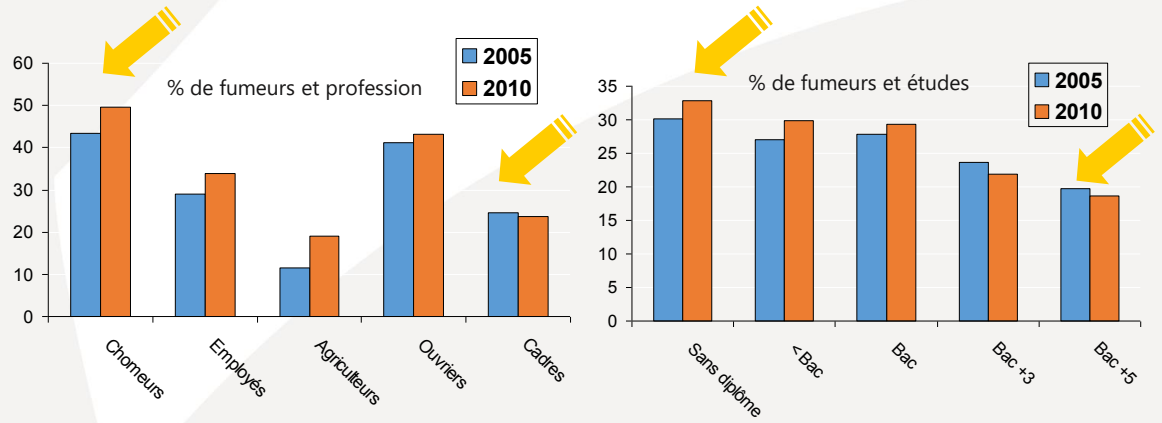


Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

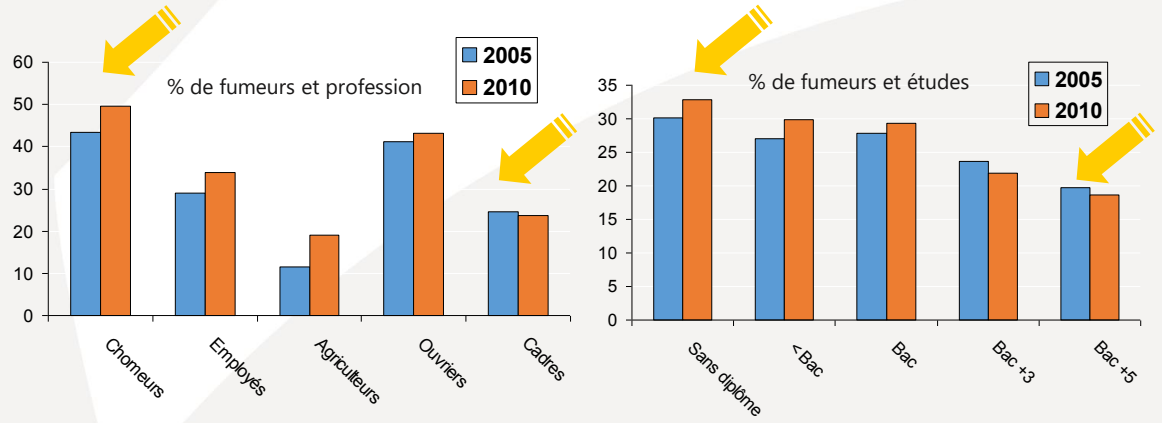
↓ tabagisme chez les cadres et les plus hauts niveaux d'étude en 5 ans
↑ pour les autres



Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

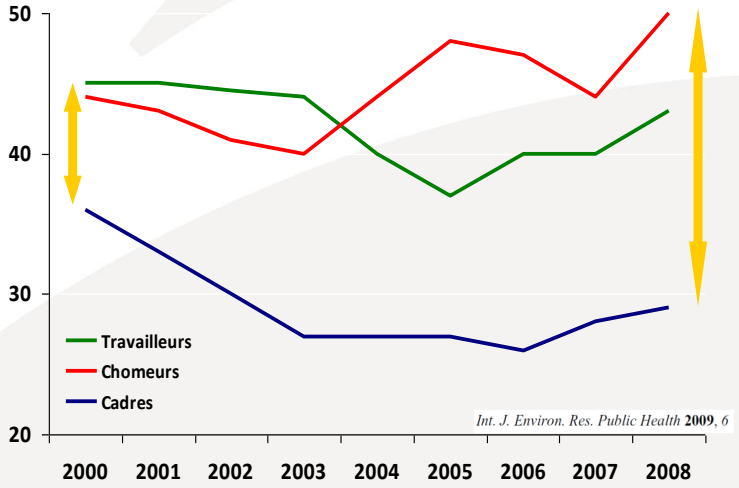
↓ tabagisme chez les cadres et les plus hauts niveaux d'étude en 5 ans
↑ pour les autres



Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Creusement de l'écart entre chômeurs et cadres au cours du temps

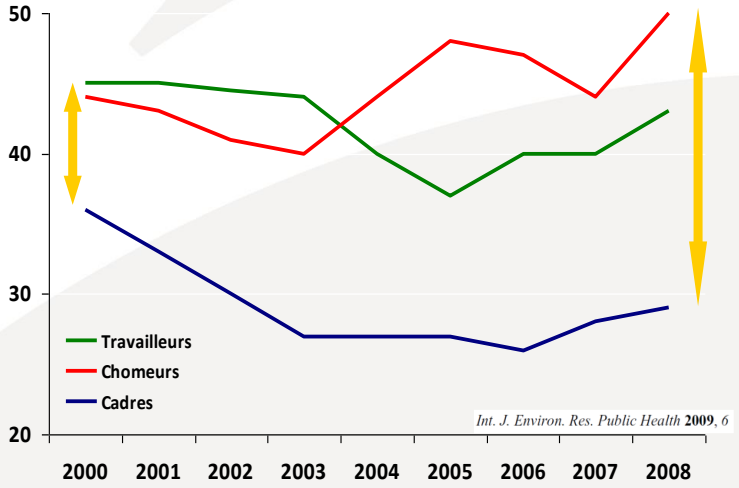


Prévalence des fumeurs en fonction de la profession, INPES, France

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Creusement de l'écart entre chômeurs et cadres au cours du temps

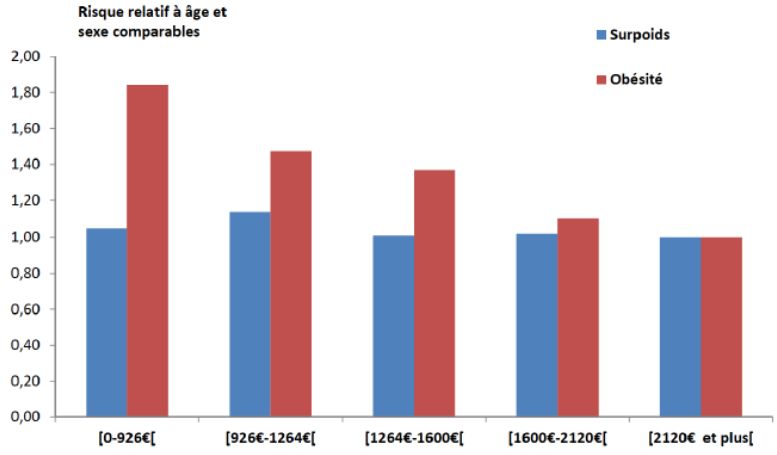


Prévalence des fumeurs en fonction de la profession, INPES, France

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

↑ obésité quand revenus ↓

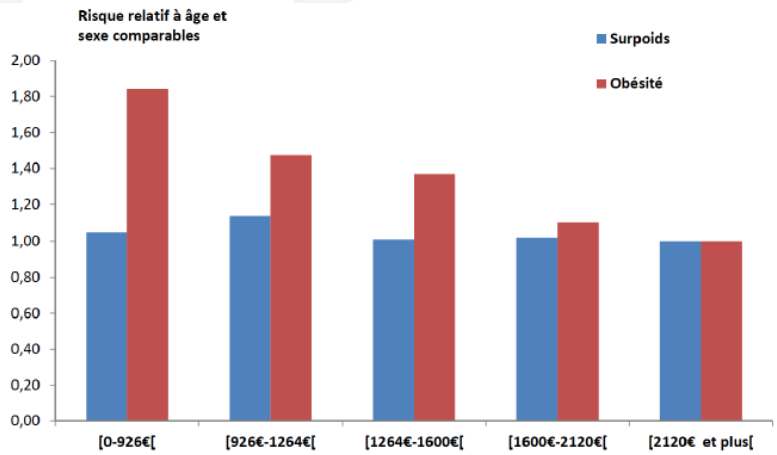


Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

↑ obésité quand revenus ↓



Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Gradient présent dès la maternelle

Prévalence de la surcharge pondérale et de l'obésité selon le groupe socioprofessionnel des parents

Groupe socioprofessionnel des parents	Surcharge pondérale (en %)		Obésité (en %)	
	2006	2013	2006	2013
Cadres	8,7	7,2	1,3	1,3
Professions intermédiaires	10,4	10,2	1,9	2,4
Agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise	13,6	13,8	3,5	4,8
Employés	13,6	14,3	3,5	4,8
Ouvriers	15,6	15,6	5,4	5,8
Ensemble	**12,4**	**11,9**	**3,2**	**3,5**

Note • L'origine sociale de l'enfant est déterminée à partir du groupe socioprofessionnel des parents (encadré 3).
Champ • France (hors Mayotte).
Sources • DREES-DGESCO, Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (années scolaires 1999-2000, 2005-2006, 2012-2013).

Université Paris Cité

Comportements favorables à la santé

Gradient présent dès la maternelle

Prévalence de la surcharge pondérale et de l'obésité selon le groupe socioprofessionnel des parents

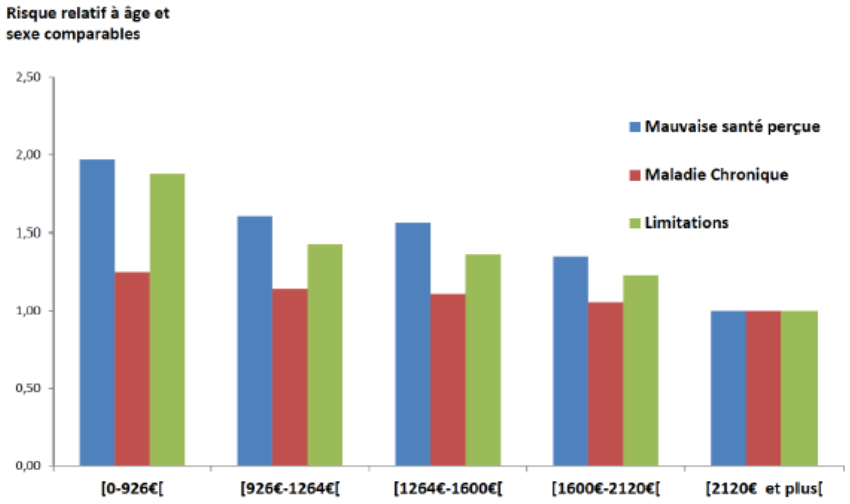
Groupe socioprofessionnel des parents	Surcharge pondérale (en %)		Obésité (en %)	
	2006	2013	2006	2013
Cadres	8,7	7,2	1,3	1,3
Professions intermédiaires	10,4	10,2	1,9	2,4
Agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise	13,6	13,8	3,5	4,8
Employés	13,6	14,3	3,5	4,8
Ouvriers	15,6	15,6	5,4	5,8
Ensemble	**12,4**	**11,9**	**3,2**	**3,5**

Note • L'origine sociale de l'enfant est déterminée à partir du groupe socioprofessionnel des parents (encadré 3).
Champ • France (hors Mayotte).
Sources • DREES-DGESCO, Enquête nationale de santé auprès des élèves de grande section de maternelle (années scolaires 1999-2000, 2005-2006, 2012-2013).

Université Paris Cité

Santé déclarée

Gradient social de morbidité avec le revenu…

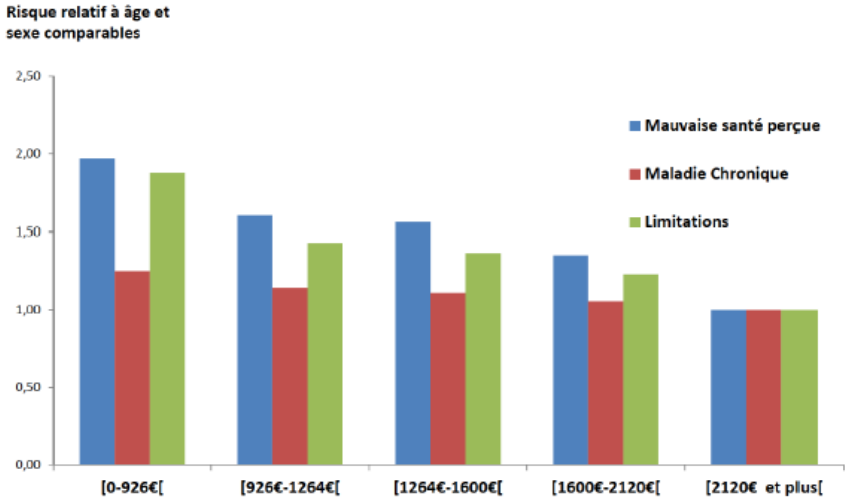


Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Santé déclarée

Gradient social de morbidité avec le revenu…



Source: d'apres Célant N., Guilaaume S., Rochereau t. (2014) « Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 », les rapports de l'irdes, n° 556

Université Paris Cité

Santé déclarée

… le niveau d'étude…

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon le niveau d'études (en pourcentage)

Niveau de diplôme	Part de la population déclarant…			Part dans la population totale
	être au moins en assez bonne santé[a]	avoir un problème de santé chronique[b]	avoir une limitation d'activité[c]	
Sans diplôme ou CEP	80,5	50,4	40,2	30,3
CAP – BEPC	92,5	31,0	18,8	9,7
BAC – BAC + 2	93,9	28,9	16,3	38,8
Diplôme supérieur	97,3	23,6	11,3	21,2
Total	**90,4**	**34,5**	**22,7**	**100**

a. Libellé de la question : « *Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais.* »
b. Libellé de la question : « *Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?* »
c. Libellé de la question : « *Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ?* »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

Université Paris Cité

Santé déclarée

… le niveau d'étude…

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon le niveau d'études (en pourcentage)

Niveau de diplôme | Part de la population déclarant… : être au moins en assez bonne santé[a] | avoir un problème de santé chronique[b] | avoir une limitation d'activité[c] | Part dans la population totale

Sans diplôme ou CEP 80,5 50,4 40,2 30,3
CAP – BEPC 92,5 31,0 18,8 9,7
BAC – BAC + 2 93,9 28,9 16,3 38,8
Diplôme supérieur 97,3 23,6 11,3 21,2
Total 90,4 34,5 22,7 100

a. Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais. »
b. Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
c. Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

Université Paris Cité

Santé déclarée

… et la catégorie socioprofessionnelle

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (en pourcentage)

	Part de la population déclarant…			Part dans la population totale
	être au moins en assez bonne santé[a]	avoir un problème de santé chronique[b]	avoir une limitation d'activité[c]	
Agriculteurs exploitants	96,1	21,0	11,8	1,3
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	97,1	22,1	13,7	3,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures	98,1	20,6	8,8	7,6
Professions intermédiaires	97,8	23,0	10,3	13,3
Employés	95,4	25,8	14,1	17,4
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles)	94,2	25,1	15,6	13,8
Retraités	80,0	59,3	43,4	29,1
Autres inactifs	90,3	26,4	20,3	14,2
Total	**90,4**	**34,5**	**22,7**	**100,0**

a. Libellé de la question : « *Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais.* »
b. Libellé de la question : « *Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?* »
c. Libellé de la question : « *Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ?* »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

Université Paris Cité

Santé déclarée

… et la catégorie socioprofessionnelle

Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (en pourcentage)

	Part de la population déclarant…			Part dans la population totale
	être au moins en assez bonne santé[a]	avoir un problème de santé chronique[b]	avoir une limitation d'activité[c]	
Agriculteurs exploitants	96,1	21,0	11,8	1,3
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	97,1	22,1	13,7	3,3
Cadres et professions intellectuelles supérieures	98,1	20,6	8,8	7,6
Professions intermédiaires	97,8	23,0	10,3	13,3
Employés	95,4	25,8	14,1	17,4
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles)	94,2	25,1	15,6	13,8
Retraités	80,0	59,3	43,4	29,1
Autres inactifs	90,3	26,4	20,3	14,2
Total	**90,4**	**34,5**	**22,7**	**100,0**

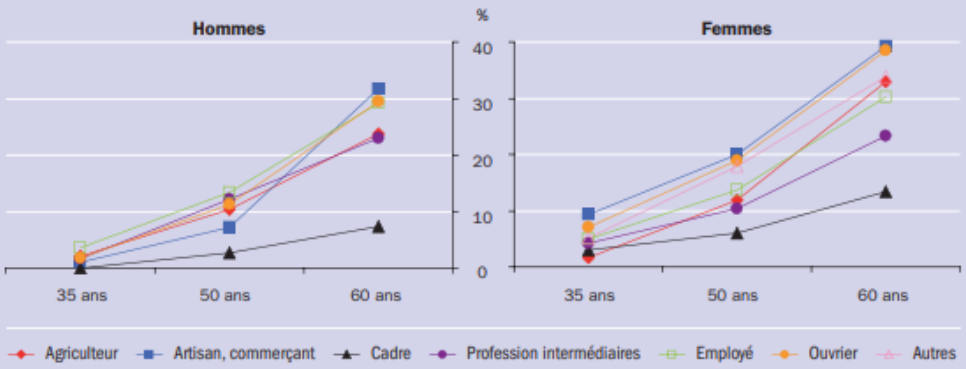
a. Libellé de la question : « *Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon, mauvais, très mauvais.* »
b. Libellé de la question : « *Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?* »
c. Libellé de la question : « *Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ?* »
Champ : Personnes âgées de plus de 15 ans vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.
Sources : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2007, Insee.

Université Paris Cité

Santé déclarée

Chez les hommes de 60 ans ++ mais présent à tous les âges

Proportion de personnes jugeant leur santé altérée à 35, 50 et 60 ans, selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle à 35 ans



Champ : personnes âgées de 60 à 74 ans, vivant en France métropolitaine.
Lecture : parmi les hommes qui étaient cadres en début de carrière (*i.e.* à 35 ans), 1 % jugeaient leur santé altérée à 35 ans, puis 3 % à 50 ans et 7 % à 60 ans. Parmi ceux qui étaient ouvriers en début de carrière, 2 % jugeaient leur santé altérée à 35 ans, contre 11 % à 50 ans et 30 % à 60 ans. Pour des raisons d'effectifs trop faibles, la CS « autres » n'est pas représentée sur le graphique « Hommes ».

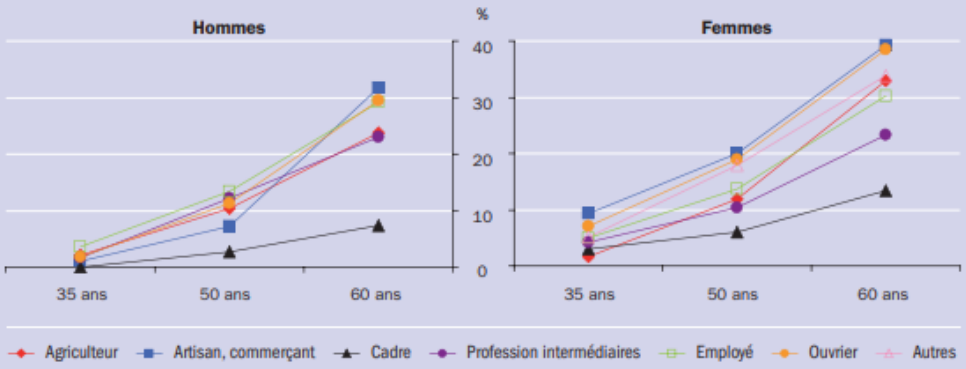
Source : Santé et Itinéraire professionnel 2006.

Université Paris Cité

Santé déclarée

Chez les hommes de 60 ans ++ mais présent à tous les âges

Proportion de personnes jugeant leur santé altérée à 35, 50 et 60 ans, selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle à 35 ans



Champ : personnes âgées de 60 à 74 ans, vivant en France métropolitaine.
Lecture : parmi les hommes qui étaient cadres en début de carrière (*i.e.* à 35 ans), 1 % jugeaient leur santé altérée à 35 ans, puis 3 % à 50 ans et 7 % à 60 ans. Parmi ceux qui étaient ouvriers en début de carrière, 2 % jugeaient leur santé altérée à 35 ans, contre 11 % à 50 ans et 30 % à 60 ans. Pour des raisons d'effectifs trop faibles, la CS « autres » n'est pas représentée sur le graphique « Hommes ».

Source : Santé et Itinéraire professionnel 2006.

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Persistance des ISS car :

- Causes combinées, cumulées par les mêmes catégories de populations
  - Environnement professionnel (travail physiquement pénible, de nuit, exposition aux produits toxiques, etc.)
  - Habitat (bruit, mauvaise qualité de l'air ou de l'eau, etc.)
  - Comportements défavorables à la santé
- Disparités qui s'inscrivent dans le temps
  - Inégalités au cours de la grossesse
  - Dès la maternelle
  - Qui se poursuivent au cours du temps
- Messages de prévention universelle pouvant dans certains cas les creuser

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Persistance des ISS car :

- Causes combinées, cumulées par les mêmes catégories de populations
  - Environnement professionnel (travail physiquement pénible, de nuit, exposition aux produits toxiques, etc.)
  - Habitat (bruit, mauvaise qualité de l'air ou de l'eau, etc.)
  - Comportements défavorables à la santé
- Disparités qui s'inscrivent dans le temps
  - Inégalités au cours de la grossesse
  - Dès la maternelle
  - Qui se poursuivent au cours du temps
- Messages de prévention universelle pouvant dans certains cas les creuser

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Trois recommandations principales de l'OMS :

- Améliorer les conditions de vie et d'accès aux soins
- Lutter contre l'inégalité de répartition des ressources, de l'emploi, du pouvoir
- Mesurer le problème, l'analyser et mesurer l'efficacité de l'action
  - Etudes épidémiologiques (déjà nombreuses)
  - Comprendre les mécanismes
  - Evaluation des interventions

Université Paris Cité

Et maintenant ?

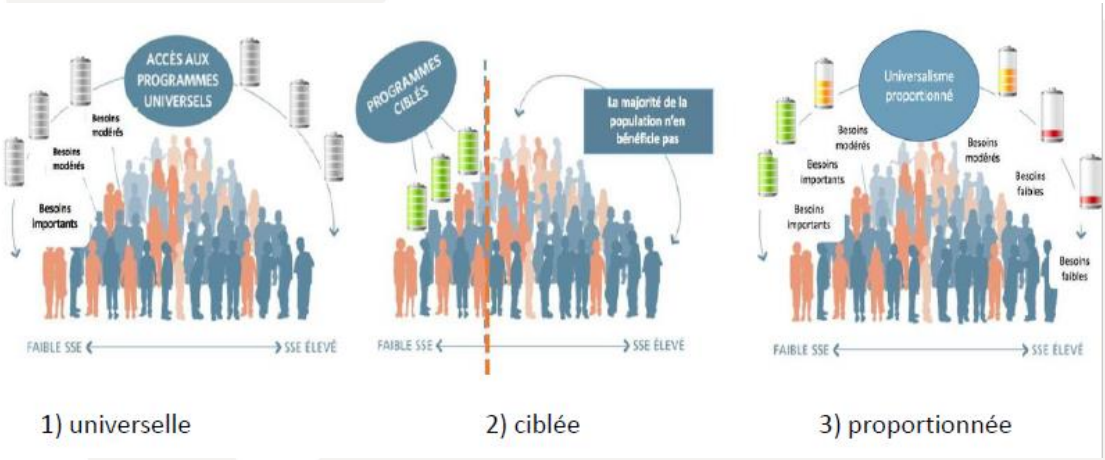
Trois recommandations principales de l'OMS :

- Améliorer les conditions de vie et d'accès aux soins
- Lutter contre l'inégalité de répartition des ressources, de l'emploi, du pouvoir
- Mesurer le problème, l'analyser et mesurer l'efficacité de l'action
  - Etudes épidémiologiques (déjà nombreuses)
  - Comprendre les mécanismes
  - Evaluation des interventions

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Trois approches pour agir

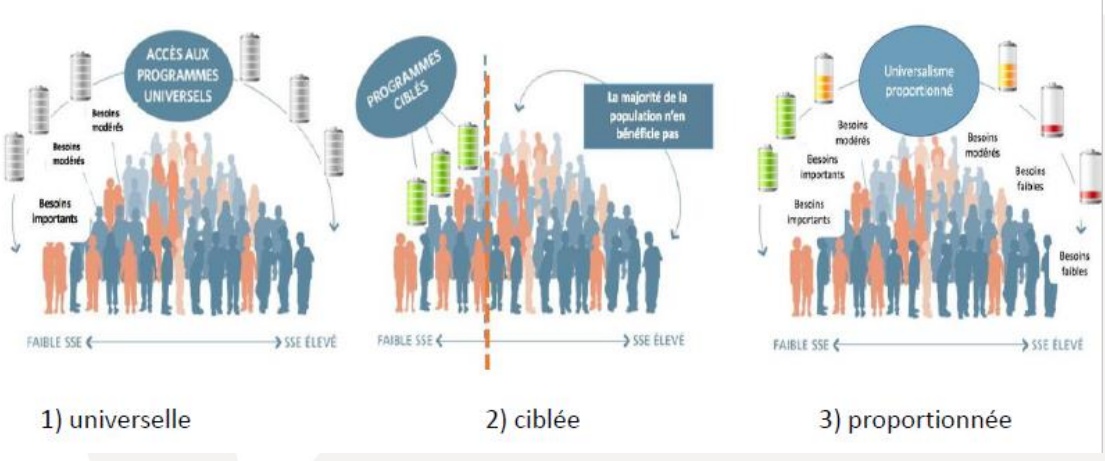


1) universelle 2) ciblée 3) proportionnée

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Trois approches pour agir

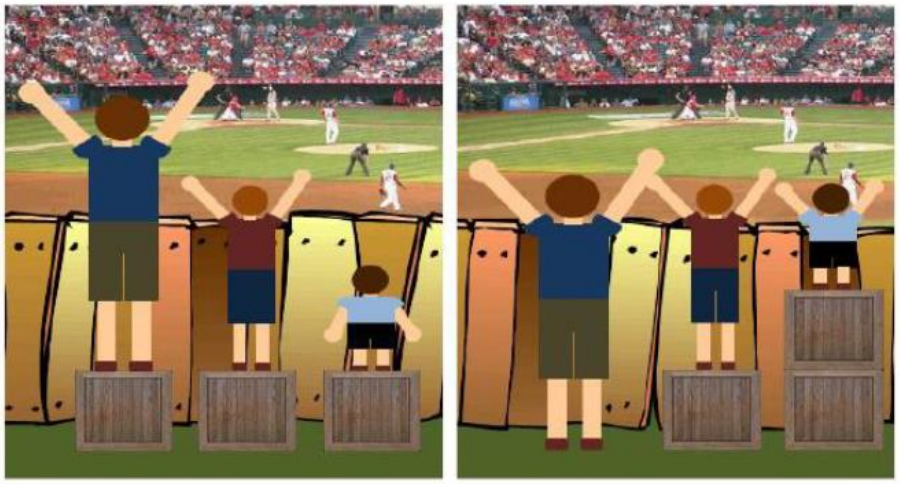


1) universelle 2) ciblée 3) proportionnée

Université Paris Cité

Et maintenant ?

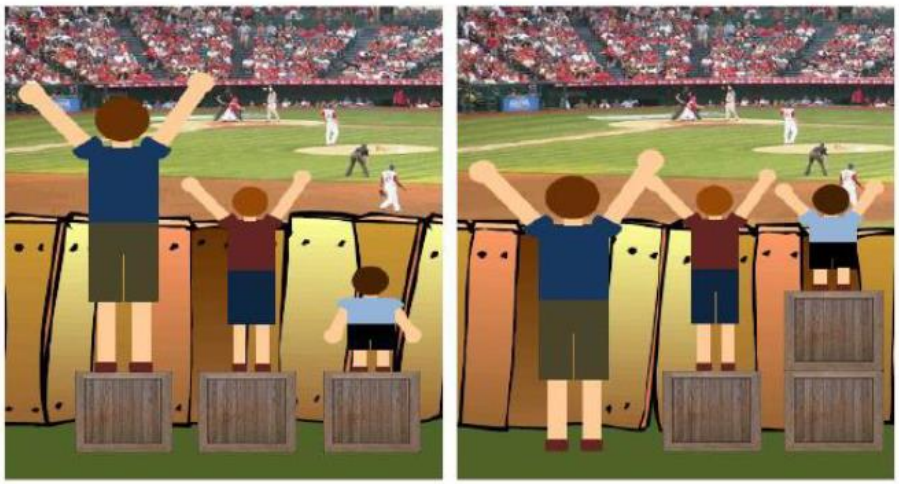
Universalisme proportionné
Intervention avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels se heurtent certains groupes



Université Paris Cité

Et maintenant ?

Universalisme proportionné
Intervention avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels se heurtent certains groupes



Université Paris Cité

Et maintenant ?

Universalisme proportionné
≠ ciblage
Cibler seulement les populations défavorisées est insuffisant pour réduire les inégalités et comporte des risques :

- de stigmatiser un sous-groupe
- d'assimiler leurs modes de vie aux causes des inégalités de santé
- de négliger les besoins des groupes intermédiaires, non inclus dans le ciblage, dont l'état de santé peut être très proche de celui des groupes ciblés

Université Paris Cité

Et maintenant ?

Universalisme proportionné
≠ ciblage
Cibler seulement les populations défavorisées est insuffisant pour réduire les inégalités et comporte des risques :

- de stigmatiser un sous-groupe
- d'assimiler leurs modes de vie aux causes des inégalités de santé
- de négliger les besoins des groupes intermédiaires, non inclus dans le ciblage, dont l'état de santé peut être très proche de celui des groupes ciblés